טיפול בהורות
גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם
עורכת: פרופ' אסתר כהן, 2017
הוצאת אח

04-8727227
בוקשוק (חיים-0526109116)



מסרים מרכזיים

- **הדרך הטובה ביותר לסייע בהתמודדות עם בעיות של ילדים היא לעבוד עם הוריהם (ברמת המעורבות וההשקעה המקסימלית האפשרית של ההורים).**

Working with parents makes therapy work (Novick & Novick,2005)

האמירה מבוססת על עדויות מחקריות וקליניות בטיפול בבעיות מגוונות של ילדים מבעיות התנהגות, הפרעות חרדה, דכאון ואובדנות, הפרעה פוסט-טראומטית והפרעות אכילה.

עם זאת לא הוטמעה דייה בקרב מטפלים רבים ומוסדות. נראה שחשוב לעזור למטפלים להתגבר על המכשולים הרגשיים ושל ידע מקצועי ביחס לעבודה עם הורים. במקביל יש לעזור למוסדות טיפוליים להגמיש את הסטינג הנקבע פעמים רבות אוטומטית, ללא שקול דעת ענייני (כולל בבחירת מטפל אחד או שניים).

- **אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן *(רבי נחמן מברסלב).***

- **טיפול בבעיות ילדים מצריך גישה טיפולית אינטגרטיבית קוהרנטית עם מפת דרכים ושיקולי דעת מבוססים תיאורטית ומחקרית.**

רציונל למעורבות הורים בטיפול בבעיות ילדיהם

--תיקון עוול היסטורי (ונוכחי) בהתייחסות להורים בפרקטיקה הפסיכולוגית*:
כולל הדרה מקסימלית של ההורים מן הטיפול וראייתם כלא-רלבנטיים (מ. קליין), דרך "האשמת אימהות" (אוטיזם), שליחת אימהות לפסיכואנליזה, והדרכת הורים שיפוטית-סמכותית.

--התקוממות נגד "מודל המוסך" – למרות הפיתוי הגדול שלו – (ההורה קלקל והמטפל יתקן) ילד איננו מכונית וחדר הפסיכולוג איננו מוסך לתיקוני רכב, אם כי יש בשניהם יש איש מקצוע מיומן.

תם העידן בו ניתן להצדיק את תפיסת ההורים כאלה ש"קילקלו את הילד" והמטפלים כאלו שירפאו אותו ויחזירו אותו הביתה במצב "מתוקן" כמו מכונית שהוכנסה למוסך.

--יתר על כן **הפיצול** שבין "ההורה-הרע" או "הלא-מבין" לבין "המטפל הטוב והמבין" עשוי ליצור נזק בתהליכי ההפנמה וההזדהות עם הדמות ההורית ובבניית עצמי קוהסיבי אצל הילד.

מודל המוסך המסורתי מדגיש את הפגימות של הילד וגם את הפגימות של ההורה, בעוד שעבודה עם הורים כסוכני שינוי מעצימה ובעלת אפקט מניעתי*.

קידום יעילות טיפולית והוגנות

--**חוסר היעילות של "מודל המוסך" בולט מול הידע המחקרי** העצום שיש בידינו כיום על האימפקט המשמעותי לאורך החיים של יחסי ההורים עם הילד והשפעתם על איכות ההתפתחות וההסתגלות של הילד כולל:

ההשפעה הישירה של אפיוני ההורים ודפוסי ההורות על התפתחות ילדיהם והסתגלותם לאורך החיים (לדוגמא בתחום ההתקשרות).

ההשפעה המתווכת החזקה של הורות על השפעות אחרות על התפתחות ילדים: גנטיקה, טמפרמנט, אירועים טראומטיים, השפעות בני הגיל, ויעילות טיפול (כולל טיפול תרופתי).

מחקר על **יכולת ההשתנות של מבוגרים** בשלבי ההורות. המחקר מצביע על שינויים ביכולות ויסות רגשי משך החיים בעקבות התנסויות בינאישיות מיטיבות, משמעות השינוי איננו רק בניית "ביטחון נרכש", אלא הרחבה של המוח הימני ושל יכולותיו לנהל רגשות וקשרים בינאישיים Schore

מחקרי יעילות טיפוליות – מטה אנליזות של מחקרים על טיפול בילדים מראה אפקט שיפור משמעותי של תוצאות הטיפול בילד עם ההורים מעורבים במידה משמעותית (Palmer, Nascimento & Fonagy, 2013; Dowell. & Ogles, 2010). במיוחד עם ילדים צעירים וטיפולים הורה-ילד.

יש פחות נשירות מטיפול ישיר בילד (60%) כשאותו מטפל רואה את ההורים וכשההורים מרגישים תמיכה מהמטפל ואינם מרגישים שהטיפול מאיים על יחסי המשפחה (מחקר ממרכז אנה פרויד בלונדון Midgley & Navridi, 2006) .

טיפול בילדים ובמתבגרים ללא שיתוף הורים עשוי לפגוע ביחסי משפחה ומגדיל סטיגמה למתבגר (Midgley & Kennedy, 2011)

שיקולים פרגמטיים:

מוטיבציה הורית ומוטיבציה של הילד וסטיגמה - הורים רבים לוקחים אחריות ומבקשים להיעזר ולעזור בעצמם לילדם. אחרים מבקשים לצמצם מעורבות מתוך חרדה ובושה, שניתן להפיגם, או חוסר ידע. עם זאת בעוד ילדים ומתבגרים רבים מתנגדים לבוא לטיפול או לשתף בו פעולה (בעיות התנהגות*, אנקופרסיס, בעיות חרדה, הפרעות אכילה). פעמים רבות המוטיבציות של הילד משתנות עם התחלת המעורבות ההורית.

במחקריו של אלי ליבוביץ לגבי ילדים עם הפרעות חרדה, אחד הממצאים החשובים היא שבמקרים בהם הילד מתנגד לטיפול אינדיבידואלי (כ-50% מן הילדים שסובלים מהפרעת חרדה), ניתן להשיג תוצאות משמעותיות בעבודה עם ההורים בלבד. בנוסף, עבודה עם ההורים מקטינה משמעותית את הסירוב של הילד ללכת לטיפול אינדיבידואלי

(בתום עשרה מפגשים של הדרכת הורים 70% מן הילדים שקודם סירבו לכך, היו מוכנים לקבל CBT).

האימפקט של שינוי בהורות הוא עצמתי ומתמשך לאין שיעור מאימפקט של מטפל (בהכרח זמני) על הילד. אימפקט ההצלחה ההורית בהקלה על בעיית הילד תורם גם לילדים אחרים במשפחה, ולכל היחסים במשפחה, ולמעשה ההורה מפיק מכך חווייה של צמיחה התפתחותית רגשית, מקבילה לטיפול אינדיווידואלי *(מקרה אסתר במברגר בספר). להורים רבים זו הזדמנות לתיקון העבר שלהם.

נימוקים לשיתוף ההורים בטיפול

1. ההורה מכיר את הילד טוב יותר מכל אדם
2. להורה איכפת מהילד יותר מכל אדם
3. הילד מושפע מן ההורה יותר מאשר מכל אדם אחר (גם אם נלחם בהשפעתו)
4. להורים השפעה חזקה יותר על הילד הן מבחינת מספר השעות, הימים והשנים שנמצא איתו והן מבחינת איכות הקשר ביניהם, המודלינג שלהם, והפרקטיקות שלהם.
5. המחקר מראה כי הטיפול מצליח יותר וקצר יותר אם ההורים שותפים לתהליך
6. באמצעות ההשתתפות בטיפול בילד ילמד ההורה להכיר את ילדו טוב יותר, להבין אותו ואיך לעזור לו ולהיות איתו בקשר טוב יותר
7. באמצעות ההשתתפות בטיפול בילד יקבל ההורה עצמו תמיכה, הבנה עצמית ומשפחתית וכלים כדי להתמודד עם הילד. תהיה זו חויית צמיחה עבור ההורה.
8. ההשתתפות בטיפול תסייע להורה גם בהתמודדות עם צרכים של ילדיו האחרים
9. השתתפות ההורה תשדר לילד שהוא איננו נתפס כ"מואשם" או "לא בסדר" ושההורה לוקח אחריות על סיוע לו ושיפור הקשר ביניהם
10. בפגישות המלוות את הטיפול בילד ניתן לגשר בין תפיסות שונות וקונפליקטים בין ההורים ביחס לילדיהם.

מהו טיפול בהורות

טיפול בהורות מתמקד בבעיות ילדים ובקשיים ביחסי הורה־ילד, ומקשר בין מטרות ההורה, חוויית ההורות שלו ועולמו הפנימי, לבין התנהגותו במפגש עם האפיונים, עולמו הפנימי והתנהגותו של ילדו.

.

ב"טיפול בהורות" ההורה נתפס כסוכן השינוי העיקרי, (או לפחות משמעותי), ומגויס לתפקיד זה, תוך הדגשה של חשיבות הקשר שלו עם הילד, ותוך כיבוד האכפתיות והאחריות שלו. המטפל רואה עצמו פעיל ואחראי, אך בו בזמן הוא תופס את ההורה שותף חשוב והכרחי. אנחנו מעוניינים במיצובם של ההורים כדמות ההתקשרות הבטוחה לילד ובמיצובם של ההורים כ- care-givers רגישים, יעילים ומסופקים.

"טיפול בהורות" מתבצע הן כטיפול מרכזי ויחיד בבעיות ילד, והן בשילוב עם פגישות של טיפול ישיר בילד, טיפול משפחתי או דיאדי. שיקולי הדעת לגבי הטיפול הנוסף לטיפול בהורות ועיתויו קשורים במצבם הרגשי והתפקודי של ההורים, מצב היחסים במשפחה, ונתונים של הילד.

- טיפול בהורות איננו דומה למפגשי הורים המתקיימים לצורך תהליכי התעדכנות עם ההורים לגבי הטיפול הפרטני של הילד.

יעוץ והדרכה מול טיפול בהורות

טיפול בהורות שונה מהדרכת הורים וייעוץ להורים (אם כי פעמים רבות כולל אלמנטים של Psycho-education). מניסיוננו, הסברים והמלצות מופנמים ומיושמים רק אצל חלק מההורים (שהם בעלי רמה גבוהה של מוכנות לשינוי וחוסן, או לחילופין במקרים קיצוניים של משבר). הורים רבים זקוקים לתהליך מורכב יותר כדי לקבל, להפנים ולשנות תפיסות, רגשות והתנהגות בקשר עם ילדם.

על פי עקרונות קונסולטציה בבריאות הנפש (2004) Caplan לגבי **תחומי חסר הוריים תוך מיקוד בנועץ-**

- **חסר בידע** – התערבות קצרה של פסיכו-אדוקציה ויעוץ
- **חסר בכישורים** – אימון, מודלינג, משחק-תפקידים

השלמת ידע וטיפוח כישורים מצליחים יותר כשנעשים באוירה של קשר בטוח המאפשר מנטליזציה.

- **חסר בביטחון + חסר באובייקטיביות** –מחייבים התערבות שהיא טיפול בהורות ממוקד התקשרות ורגש

אפיוני טיפול בהורות

- "טיפול בהורות" שונה מטיפול אישי להורה, אם כי לצורך התרת תקיעות או ויסות סערה רגשית בקשר עם הילד עשויה להתבצע חקירה ועיבוד של סוגיה ספציפית אישית של ההורה המקושרת לבעיה עם הילד.

- טיפול בהורות ממוקד הרבה יותר מטיפול משפחתי מסורתי. לאחרונה נוטים לעבור לטיפול ממוקד בהורה במקום טיפול משפחתי. למשל בטיפול בהפרעות אכילה, מוצאים שזה מאפשר להורים לדבר על דברים אישיים, לבטא רגשות הוריים שהורים נמנעים לבטא בנוכחות ילדיהם, ומונעים תגובות הרסניות של אחאים, או את תרפוד הפגישות על ידי המתבגרת שאיננה מעוניינת לשתף פעולה בטיפול.
- (*Hughes, Sawyer,Loeb,& Le Grange,* 2015-**Parent-Focused Treatment)**

טיפול בהורות כמודל אינטגרטיבי המדגיש אינטרסובייקטיביות וממוקד התקשרות ורגש

המודל שפיתחנו שייך לקבוצה של מודלים חדשניים המייצגים את "המהפכה הרגשית", אך הוא כוללני ואינטגרטיבי יותר

- Attachment Focused family Therapy- D. Hughes
- Attachment Based Family Therapy- G. Diamond & G. Diamond
- Mentalization Based Family Therapy-Anna Freud Center
- Parent-Therapy or Parent Focused Child Therapy- Linda Jacobs
- Child Centered Family Treatment- A. Ornstein
- Parent-Focused Treatment- Hughes, Sawyer,et al.
- Child Parent Psychotherapy- A. Lieberman & P. Van Horn
- Dyadic Psychotherapy-Ben Aaron
- (Parent-child interaction therapy-Eyberg)

מיהו המטופל (מי ומה זקוק לשינוי ומי המעוניין בכך)?

The IP in child psychotherapy is the relationship (Pantone, 2000) or

The IP in child psychotherapy are the relationships

הפציינט הוא הקשר הורים- ילד

הקליינטים המרכזיים הם ההורים כי אנחנו בונים :

--על מערכת נוירולוגית מולדת- מערכת הcare-giving של ההורה המגורה על ידי מערכת המולדת של ההתקשרות של התינוק

--על פתיחות לשינויים ב"מח ההורי" במעבר להורות (עליה באוקסיטוצין).

--על המוטיבציה ההורית המושפעת מתהליכי הזדהות, בניית זהות, והפנמות תרבותיות וסידורים חברתיים של מושג האהבה ההורית ואחריות הורית.

מהו טיפול אינטגרטיבי בהורות?

- אחת מהנחות היסוד היא ששינוי בהתנהגות-אינטראקטיבית משנה ייצוגים פנימיים ושינוי בייצוגים פנימיים משנה התנהגות באינטראקציה (Stern,1989-Stern-Bruschweiler &;). זה מאפשר פתחי כניסה שונים להתערבות בתנאי שמחזיקים בראש השפעות הדדיות אלה (התערבות אקלקטית לעומת אינטגרטיבי). כך למשל הצעת שינוי התנהגותי מבוסס על הייצוגים של האם ומתוכנן כסמל בעל משמעות שישפיע על הייצוגים של הילד וההורה. העבודה על הייצוגים היא לא לעומת- אלא במקביל -לעבודה על התנהגות אינטראקטיבית.
- מדובר כאן על גישה של cyclical psychodynamics (Wachtel P., 2014) כחלק מתאוריה התייחסותית, המדגישה כי המבנה הנפשי הפסיכודינמי ודפוסי קשר והתנהגות, מושפעים מעגלית והדדית ולאורך זמן. האדם משליך על המציאות את התכנים ואת הדפוסים המאכלסים את עולמו הפנימי, וכך מעצב את העולם שאותו הוא חווה. דפוסים ותכנים פנימיים אלה משתמרים, או משתנים באמצעות התנסויות בעולם.

מיקוד אינטגרטיבי = מיקוד כפול

- מיקוד הן בסימפטום ההתנהגותי והן בצרכים הפנימיים-האישיים של נושא הבעיה (Omer, 1993). שני מוקדים אלה קשורים באמצעות ההמשגה מחדש המחברת בין הסימפטום ובין ההבנות ההתפתחותיות וההתייחסותיות.
- מיקוד כפול זה מאפשר לגייס את המוטיבציה של המטופלים המתקשים לעתים לעסוק באחד משני המוקדים, באמצעות האפשרות לעבור, לפחות זמנית, למוקד האחר. עומר מציין כי המוקד הכפול מקל גם על המטפל, משום שהוא פותח לו אפשרויות התערבות רבות שיש ביניהן רציונל מקשר.
- דוגמאות-

מוקד הטיפול

טיפול בהורות הוא קודם כל **התערבות מבוססת קשר, דיאלוגית, ונענית בגמישות לצרכי ההורה, תוך כדי התאמה לנסיבות הפנייה.**

דגש מרכזי מושם על תפקיד המטפל **בקידום הויסות העצמי של ההורה לצורך וויסות הדדי של הורה-ילד וויסות הילד.** זאת מתוך אמונה שבזכות המרחב הטיפולי שנוצר על ידי החזקת "הראש" של ההורה (בנוסף ל"ראש של הילד") ב"ראש" של המטפל על ידי הבנת חוויית ההורה, רגשותיו, דפוסי החשיבה שלו ומטרותיו ההורה יכול ליצור מחדש את הילד ב"ראש" שלו. בהמשך נוכל לחתור עם ההורה להשגת מטרותיו בדרך מותאמת לנתוני וצרכי הילד, תוך הפעלתו כסוכן השינוי. כמו בטיסה אנחנו מאמינים שבעת חרום **יש להנגיש את מסכת החמצן קודם להורה ואחר כך לילד.**

המטפל הוא גם מומחה לתוכן וגם מומחה לתהליך. לכן איננו רק קונסולטנט העוזר להורה לעזור לילדו, אלא יחסיו עם ההורה והתהליך הטיפולי אמורים להיות מופנמים, ליצור שינוי בייצוגים פנימיים וגם לשמש מודל ליחסי הורה־ילד. כך מתקיימים בטיפול ובבית **תהליכים מקבילים.**

Connect before you redirect (Siegel)

עמדת המטפל

- מאמין שהכוונות של ההורים והמוטיבציה להיות הורים טובים חזקה גם אם היא כרגע חסומה; שהיו להם תקופות שהצליחו יותר או תחומים בהם מצליחים גם עתה. הוא מחפש עדויות לאמונה זו תוך תשאול ההורים. הוא מאמין שיש להם פוטנציאל להצליח יותר, כשהחסמים יזוהו ויוסרו, ולכן מחזק את המשמעות המיטיבה של פניית ההורה לטיפול ומתעניין בחזון ההורי שלהם.
- המטפל מבטא חוסר שיפוטיות ואמפטיה לגבי תחושות ומחשבות ביחסיהם עם הילדים, וקבלה של הצורך בהגנה רגשית כדי להפחית חרדה, בושה, יאוש, וכאב רגשי.
- המטפל שם דגש על אמוציות הוריות לא רק כפי שהן מדווחות, אלא כפי שהן נחוות, הן ברגע ההתרחשות, והן בעת הדיווח עליהם בנוכחות המטפל.
- הוא מתעניין ביכולת ודרכי הויסות שההורה נוקט בהם והסיבות לכך.

הצורך בגישה אינטגרטיבית ביחס לבעיות ילדים

- **No one perspective sufficiently addresses the multiplicity of factors that result in emotional distress for a child** (Wachtel, 2009).

- **Children cannot and should not wait** (Solnit).

- ילדים בדרך כלל אינם פונים אלא מופנים לטיפול. לכן בטיפול בבעיות ילדים יש לנו לקוחות רבים: הורים, ילדים, מערכות חינוך ורווחה וצרך להתאים את ההתערבות לצרכיהם.

אז מה הבעיה בטיפול אינטגרטיבי בבעיות ילדים?

"לפני שהתחתנתי היו לי 6 תאוריות על גידול ילדים, עכשיו יש לי 6 ילדים ואף לא תאוריה אחת"
(ג'ון וילמוט, משורר בריטי, אמצע המאה ה-17)

- לעומת מיעוט הכתיבה הממשיגה ומדגימה טיפול אינטגרטיבי בבעיות ילדים, מחקרים בהם מראיינים מטפלים בילדים מראים שרבים מדווחים על שימוש בגישה אינטגרטיבית, על ידי שילוב מבחר טכניקות מגישה קוגניטיבית-התנהגותית עם התייחסות מערכתית וגם עם אלמנטים של תאוריה פסיכודינמית. מדובר אם כך באקלקטיות טכנית. **רכיבים לארוחה ללא מתכון**. Integrated child psychotherapy: treatment ingredients in search of a recipe (Shirk 1999), בולט בתחום קושי מרכזי באינטגרציה אסימלטיבית, כלומר תאוריה מרכזית עם חיבורים ברורים לתיאוריות נוספות ולטכניקות הנובעות מהם. אינטגרציה כזו מאפשרת מפות דרכים ושיקולי דעת הנותנים משמעות תיאורטית לבחירה בטכניקות טיפוליות.

"יש הרבה דרכים לרומא" – אבל בלי מפת דרכים מתי ובאיזה מצב רוח נגיע?

- **אמנות התאמת המסלול- המרשם – הרצפט**

התמודדות עם הלחץ של ההורה לפתרונות "כלים" מהירים ופשוטים והדחף שלנו להכנות ולשלוף עצות. סיכונים והסבר:

- "חרב פיפיות"
- אם זה היה כל כך פשוט כבר הייתם מוצאים לבד.
- לא הייתי רוצה שנכשל בגלל בדיקה ותכנון לא מספיקים

- **האתגר העיקרי בגישה אינטגרטיבית טיפולית הוא שילוב בין רפלקטיביות לאקטיביציה, בין התמקדות בחשיבה, ברגש ובהתנהגות.** הדבר הופך מסובך במיוחד כשמדובר בהתאמה לכל אחד מההורים וגם לילד.

אינטגרציה תיאורטית בטיפול בהורות באמצעות תאוריית ההתקשרות

--תיאוריית ההתקשרות שנבנתה כתאוריה התפתחותית, העשירה בביסוס מחקרי, יכולה להוות מסד תיאורטי המאפשר אינטגרציה של הגישות הטיפוליות המרכזיות (הפסיכודינמית, הקוגניטיבית-התנהגותית, והמערכתית). זאת כיון שתאוריית ההתקשרות מחברת בין **התנסויות בינאישיות ממשיות** עם תהליך היווצרות **המודל הפנימי של עבודה,** (המקביל למושג "הייצוגים הפנימיים" ו"סכימות"). המודל הפנימי ממשיך להשפיע על תהליך ההתפתחות הרגשית-חברתית, אך פתוח לשינוי בעקבות התנסויות ממשיות חדשות.

--התאוריה מאפשרת שימוש במושגים טרנס-תיאורטיים הרלבנטיים לכל הגישות הטיפוליות כמו **מושג הויסות הרגשי.** זאת משום שהיא **תאוריה של ויסות רגשי** (Schore) בעיקר של חרדה, **באמצעות קשר משמעותי** הכולל יצירת "**בסיס בטוח**" ו"**נמל מבטחים**" ומדגישה **שביסוס הביטחון הוא תנאי לחקירה ולמנטליזציה.**

--עקרונות מתאוריית ההתקשרות מתחברים עם הממצאים מתחום מדעי המח הבינאישיים והאפקטיביים ועם ממצאים על **פרקטיקה מבוססת ראיות של יעילות טיפולית.**

התקשרות ופרקטיקה מבוססת ראיות

"...אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש..." **(מאיה אנג'לו)**

(בהתבסס על סיכום של הועדה הנשיאותית של ארגון הפסיכולוגים הקנדי 2016):

– **הרגישות והגמישות שבה נערכות ההתערבויות הטיפוליות, חשובות הרבה יותר מאשר ההיצמדות הנוקשה לעקרונות טיפוליים כלשהם.** ההשפעה החזקה של העבודה הטיפולית נקבעת פחות על פי מה שהמטפל אומר למטופל, או עושה בעבור המטופל, אלא תלוייה במידה רבה יותר בדרך שהוא "עם המטופל", בניטור האפקט ובהתייחסותו במיוחד ברגעים שהם עמוסים רגשית ולוחצים.

- שיתוף הפעולה בין המטפל לבין מטופל מתרחש לא רק בשדה המילולי והקוגניטיבי, אלא בשדה האינטר־סובייקטיבי שכולל רמזים שאינם מילוליים הרלבנטיים להתקשרות. שדה זה, שהדגש בו הוא על **תקשורת של ההמיספרה הימנית של המטפל להמיספרה הימנית של המטופל**, **הוא החשוב יותר בתהליכי שינוי.**

לכן בעבודה הטיפולית עם ההורים –יש דגש על מודעות המטפל לשדרים הלא-מילוליים והדו-משמעיים שלו ושל בירורם או התאמה להם, שימוש במטפורות וסיפורים, ובדיקה אמיצה של החוייה של ההורה עם המטפל.

The Emotional Revolution

- החלק הלא מילולי בתקשורת הוא בעל אימפקט חזק יותר מהמילולי (60%), ורוב התקשורת היא RH TO RH. בטיפול הממוקד ברגש עושים ניטור צמוד של חוויית המטופל ברגע, כולל תגובות גופניות ולא-מילוליות לזיהוי התמודדויות הגנתיות, והפיכת החוויה האימפליציטית לאקספליציטית. השתהות לצורך הבנה והגדלת מורכבות. (דוגמא-"ילדי שמנת")

- הכללה לתצפיות בילד ותקשורת איתו.
- **אמפטיה נמדדת לפי המקבל, לא לפי השולח**. זוהי חויית ה"להרגיש מורגש". התרומה המיוחדת של דיאנה פושה- AEDP- בדיקה: "איך אתה מרגיש אתי? האם אתה מרגיש כמה אני איתך בעצב שלך. איך זה בשבילך כרגע כשאתה מספר לי על כך?"

- הכללה של בדיקה זו ליחסי הורה-ילד: האם אתה מרגיש כמה אני אוהבת אותך? כמה אני גאה בך?

- פרק של נטע

Mirror Neurons

הדרך בה המטפל חווה את החוויה של המטופל את האירוע מאפשר יצירת משמעות חדשה וחוויה חדשה

אמפטיה

- אמפטיה נתפסת כתהליך אקטיבי מנטלי אינטרסובייקטיבי, המתקיים בין שתי נפשות לפחות; תהליך שבו המטפל חווה אירוע שהמטופל חווה קודם והם חווים אותו עכשיו **ביחד**. חשוב שהמטופל ירגיש את השותפות של המטפל, כדי שירגיש אמפטיה כלפי עצמו. אמפטיה איננה טכניקה שבה נותנים למטופל מלים כדי שירגיש מובן. מדובר בתהליך המאפשר ויסות-הדדי של רגשות ויצירה משותפת של נרטיב.

שימוש בהמשגות טרנס-תאורטיות –ויסות רגשי

- מוקד מרכזי בטיפול הוא **שיפור הויסות רגשי של כל אחד מההורים בחדר הטיפול.** זאת כדי לקדם חקירה, רפלקציה, הבנות חדשות ושינוי.
- **קידום הויסות הרגשי של ההורים בבית** ובמשפחה חשוב כי יכולות ויסות עצמי של ילדים נרכשות באמצעות יחסי הורה-ילד. אלה מעצבים נתונים מולדים של הילד (טמפרמנט, מבנה נוירולוגי) מתווכים השפעות סביבתיות, ומפתחים מבנים פנימיים אצל הילד (מודלים של עבודה) ואסטרטגיות התמודדות. רכישת יכולות ויסות-עצמי היא מטלה התפתחותית מרכזית הקשורה להסתגלות, חוסן או לפסיכופתולוגיה בילדות ובבגרות.
- מגבלות קיצוניות ביכולות ויסות הורי מתבטאות בהתנהגויות הפוגעות בילדים פיזית ונפשית.
- המחקר העדכני מציע כי יש להתייחס ל**ויסות רגשי כתהליך טרנס־דיאגנוסטי חשוב** הפועל במרבית הפסיכופתולוגיות, כמו, הפרעת חרדה מוכללת, חרדה חברתית, הפרעות אכילה, הפרעת אישיות גבולית ובעיות הפנמה והחצנה.
- אבחנה טרנס־דיאגנוסטית של קושי של הילד בוויסות רגשי הופכת להיות הגדרה שימושית שקל להורים לקבל ולמקד בה את הטיפול.
- במקביל מוצע בעקבות המחקר להתייחס ל**ויסות רגשי כתהליך טרנס-טיפולי מועיל** של הגדלת יכולות התמודדות רגשית מעבר לאבחנה ספציפית. יש עדויות ליעילות בטיפול בדיכאון, בבעיות אכילה ובבעיות קלות יותר.

מערכות התנהגותיות של התקשרות- בולבי

- שלוש מערכות ההתנהגותיות הקשורות להתקשרות מחוייטות במח האנושי כחלק מהציוד האבולוציוני שלנו (בולבי):

- **מערכת ההתקשרות של הפרט-** שמטרתה העיקרית היא חיפוש והשגת הגנה ובטחון לעצמי. לאנשים יש סכמות שונות של התקשרות עם אנשים שונים בו זמנית וגם סגנונות ואסטרטגיות טיפוסיות ודומיננטיות. **התקשרות** = מערכת דיאדית לצורך ויסות אפקט ובמיוחד חרדה שמופנמת בצורת ייצוגים ויכולות ויסות פנימי (סיגל).

- **מערכת החקירה-** שמטרתה העיקרית לקדם למידה על הסביבה, מופעלת רק כשמערכת ההתקשרות מרגישה בטחון, ומתאוששת לאחר חווייה מתסכלת אחרי שימוש ב"נמל מבטחים".

- **ומערכת מתן הטיפול** CAREGIVING שמטרתה העיקרית היא בסיפוק הגנה (ותמיכה בחקירה) לאחר הנזקק. לכל נותן-טיפול יש ייצוגים שליליים וחיוביים של העצמי כמטפל- של האחר כמקבל טיפול- ושל האינטראקציה של מתן הטיפול.
- מתן-הטיפול מספק צרכים של רגשות חיוביים, קומפיטנטיות, וצמיחה. תהליך מתן הטיפול מתבטא בהתקרבות לנזקק (זמינות) רגישות (רפלקטיביות לגבי צרכי האחר) ותגובתיות יעילה (על ידי הבנה, טיפול, ויסות, הכוונה ועידוד).

התקשרות בלתי בטוחה והתפתחות דפוסי וויסות רגשי אצל ילדים

- ילדים שבמהלך שנתם הראשונה חוו דחייה הורית, ואשר צרכיהם בביטחון ובהרגעה לא סופקו על ידי מבוגר (ילדים המסווגים כחרדים נמנעים מבחינת איכות ההתקשרות), לומדים לאמץ בעצמם מנגנונים של הגנה לצורך ויסות רגשי. הם מגנים על עצמם מתלות ומדחייה הצפויה בעקבותיה ומנסים **לשלוט שליטת יתר** ברגשות שלהם. על ידי התכחשות והימנעות מתחושת חרדה הם מפגינים התנהגויות של הסתמכות עצמית קיצונית, או לחילופין מצמצמים מראש את תחום ההתעניינות שלהם ואת הצרכים שלהם, כך שלא יכנסו למצבי תלות ומצוקה. דפוס זה מכונה "**התקשרות נמנעת**"
- ילדים המסווגים כבעלי התקשרות חרדה אמביוולנטית או מתנגדת, אשר חוו טיפול בלתי יעיל או בלתי עקבי מראים **תת-שליטה** במצבים רגשיים ומתקשים לווסת בעצמם אפילו כמויות קטנות של מצוקה. הם נמצאים במצב כרוני של שידור מצוקה ותלות במבוגר וכל האנרגיות שלהם מושקעות בניטור הקשר עם המבוגר, שהוא תמיד מתסכל, כי המבוגר איננו מצליח להשביעו. הדפוס נקרא "**התקשרות חרדה- אמביוולנטית**".

התקשרות בלתי מאורגנת

- מצב חמור אף יותר מבחינת רכישת אסטרטגיות לוויסות רגשי מתרחש כאשר ההורה הוא מקור של אימה ולחץ עבור הילד. במצב כזה הילד עלול לפתח התקשרות בלתי מאורגנת. דפוס זה מאופיין ב'תקיעות' בלתי ניתנת לפתרון של מצבי פחד קיצוני. התנהגותם של ילדים אלה מראה חוסר באסטרטגיות ויסות ועקב כך אפיונים והתנהגויות דיסוציאטיביים; התפתחותם מאופיינת בקשיים חברתיים, בקשיים ניכרים בוויסות רגשי ובהפרעות נפשיות.

- להורים בעלי התקשרות בוגרת ובטוחה יש גם סיכוי משמעותי גבוה יותר לגדל ילדים בעלי התקשרות בטוחה. יכולות המסייעות להורים בטוחים אלו לווסת רגשות בהצלחה הן, לפי טענתם, יכולת האינטרפרטציה הבינאישית המפותחת שלהם ויכולת הקבלה המכבדת את הילד כפרט נפרד וייחודי.

התקשרות אצל מבוגרים

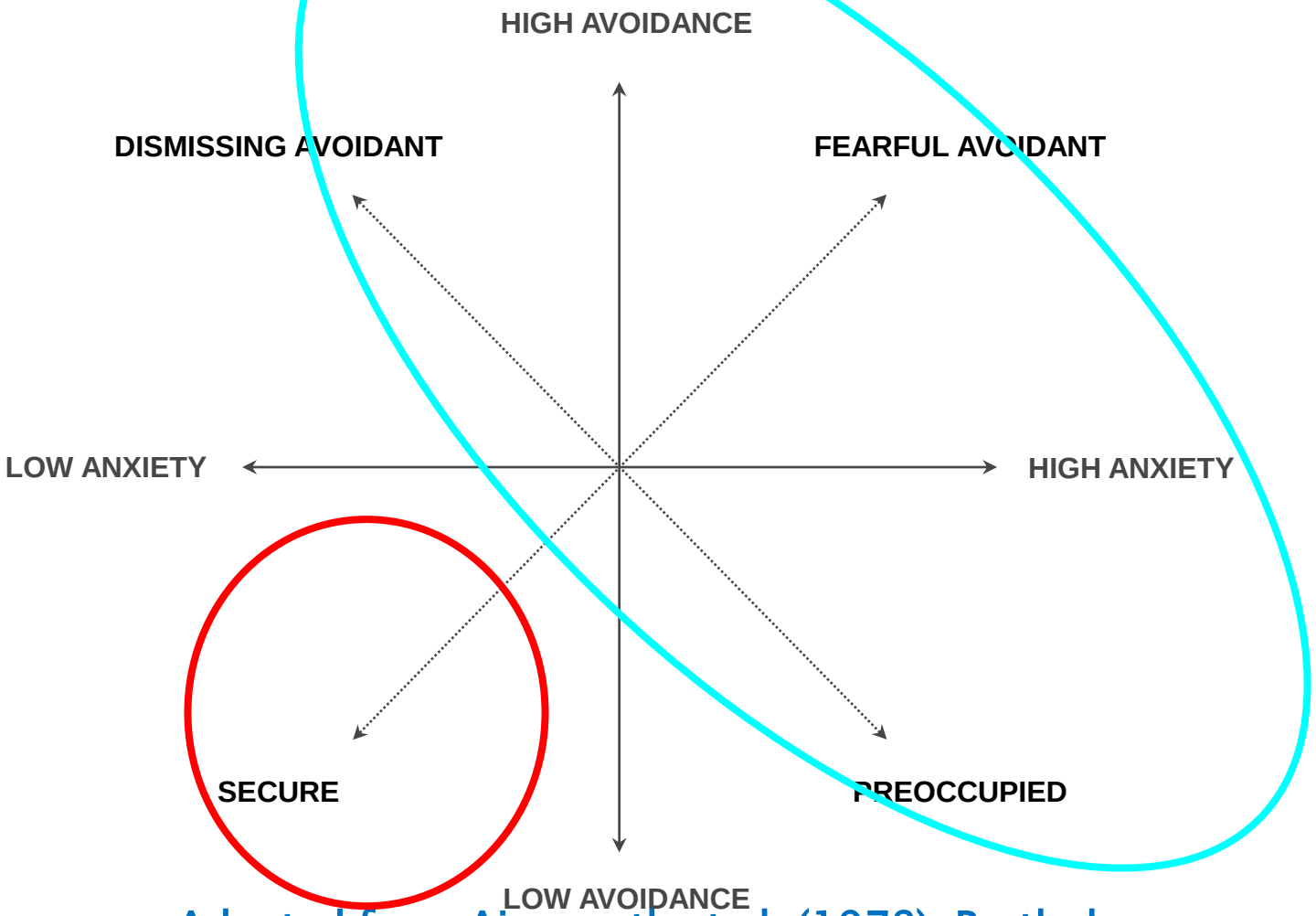
התקשרות בטוחה = ויסות תקין

התקשרות חרדה נמנעת (מבטלת) = ויסות-יתר

התקשרות חרדה אמביולנטית (מוטרדת) = תת ויסות

התקשרות בלתי-מאורגנת = אובדן ויסות

Adult attachment 'styles' in social/personality psychology: Regions in a two-dimensional space



Adapted from Ainsworth et al. (1978), Bartholomew & Horowitz (1991), Fraley & Shaver (2000)

Caregiving והורות

מערכת מחוייטת גנטית המניעה את ההורה לשמש כבסיס בטוח ולהגיב בצורה מטפלת, מגינה ותומכת-חקירה עבור הילד, אך גם עונה על צרכי העצמי של נותן הטיפול:הצורך לאהוב ולהיות נאהב, להיות אפקטיבי ונחוץ ובעל השפעה.

- טיב ה CAREGIVING קשור ב:
- הסטורית ההתקשרות של ההורה עצמו והעיבודים שנעשו אז ומאז
- בחוויות נוספות שאסף במהלך ההתבגרות והמעבר להורות כמקבל וכנותן-טיפול
- בחוויות ההצלחה, התמיכה והלחץ במהלך ההורות עצמה (אירועים טראומטיים ומוטיבציות מתחרות)
- אמוציות העולות תוך אינטראקציה עם הילד שמקורן בקוגניציות וסכמות לגבי תפקידי ההורה וידע בהתפתחות הילד

הקשר בין מערכת ההתקשרות ומערכת ה-caregiving

- חשוב להכיר במורכבות ובתחרותיות האפשרית של האינטראקציה בין מערכת ההתקשרות של ההורה ובין מערכת מתן־הטיפול, ובין מערכות אלה לבין מערכות מוטיבציוניות חשובות אחרות בחיי המבוגר (הצמדות אם לבילויים עם חבר חדש תוך הזנחת הילד).
- בייחוד קיים מתח בין מערכת **ההגנה העצמית הרגשית**, הקשורה לצרכי ההתקשרות של המבוגר לבין מערכת מתן־הטיפול (סלמה פרייברג "רוחות רפאים בחדר הילדים"; אברסיביות של בכי של ילדים).
- אפשר לתפוס קונפליקטים ביחסי הורה־ילד כנובעים פעמים רבות מאינטראקציה בין צרכי התקשרות לא מסופקים הן של ההורים והן של הילד, המתבטאים בהתנהגויות המנציחות את הבעיה. כך, הורה שמגיב באסטרטגיה של דה־אקטיבציה רגשית כלפי מתבגר מתפרץ וזועם, באמצעות התעלמות, זלזול והקטנה, מגביר בעצם התנהגותו את הנטיות של אקטיבציית יתר של המתבגר, וכך גם מתרחשת הסלמה.

זיהוי והתמודדות עם אסטרטגיות התקשרותיות הגנתיות לויסות רגשי: דה-אקטיבציה והיפר-אקטיבציה

בהקשר לתפקוד בהורות, אפשר לראות את הפעולה השונה של אסטרטגיות הגנתיות הקשורות להתקשרות לא בטוחה, כאשר מתעוררת אי־הלימה בין צרכי מתן־הטיפול ובין צרכי ההתקשרות של ההורה.

אסטרטגיות אלה כוללות מגוון דרכים של **היפר־אקטיבציה** או של **דה־אקטיבציה** רגשית בקשר עם בני המשפחה וגם עם המטפל **כדי לווסת חרדה וכאב.**

הורה עם התקשרות חרדה – אמביוולנטית יתמודד על ידי חיפוש קרבה, יגביר דרישות תובעניות לתשומת לב ויחצין גילויים אינטנסיביים של צורך לקבל מאחרים הרגעה והבטחות להגנה. פעמים רבות הורים מפעילים אסטרטגיות אלה, לא רק כלפי מבוגרים אחרים, אלא כלפי ילדיהם, בד בבד עם בקשת אישור שהילדים אוהבים ומעריכים אותם.

הורה עם התקשרות נמנעת יעשה שימוש באסטרטגיות של דה־אקטיבציה, ינסה להעניש את האנשים הנתפסים מאיימים באמצעות התרחקות ובאמצעות ביטויי כעס כלפיהם כדי להתגונן מחרדה ומכאב. בהורות מתבטאות אסטרטגיות אלה בהתרחקות ואפילו בניתוק קשר, ובנטייה להשתמש בעונשים ובהעלבות.

התייחסות מותאמת לאסטרטגיות ההתקשרות

- תפקידו של המטפל הוא לנטר את האפקט של המטופל. כך מתבררת אסטרטגיית ההתקשרות שלו ומסמנת למטפל את רמת ההתייחסות המתאימה לרגשות כולל שיקוף רגשות ותשאול על רגשות.
- כאשר התגובה אליהן היא שלילית, או מצביעה על אי־נוחות גדולה, כפי שפעמים רבות מתרחש עם הורים או ילדים הנוטים לדפוס התקשרות חרדה־נמנעת, טוב יעשה המטפל אם יעלה את המינון היחסי של ביטויים של הבנה אינטלקטואלית ושל ארגון קוגניטיבי בהתערבות שלו. המטפל ימתין להזדמנות להגיב לרגש של המטופל, כאשר זה משדר ביטחון בקשר עמו ומעורר רושם שהוא מוכן לרופף את הצורך ההתקשרותי שלו בוויסות יתר של רגש. לעתים, אזכור תגובה אישית של המטפל במצב דומה, או של אחרים, שימוש בטון משחקי או שימוש במטפורה, יאפשרו התקרבות לחוויה הרגשית של מטופל נמנע.
- באותה מידה פעמים רבות, מטופל חרד־אמביוולנטי המבטא בחדר מוצפות רגשית וקושי בוויסות רגשי, זקוק לעזרה בטיפוח יכולת הרגעה עצמית ובארגון והובלה ממוקדים, נוסף על התגובה האמפתית המילולית המארגנת והממתנת. יש לנסות לזהות את ההבדל בין "רגשיות - אמוציונאליות" ובין "רגש - אמוציה", באמצעות התמקדות ברגש כלפי חוויה עכשווית, במקום היסחפות לכיוונים שאינם ממוקדים. בנוסף חשובה ההדגשה של ההבדל בין חוויית המדווח ובין חוויותיהם של אחרים.

התקשרות וחקירה-השלכות לטיפול

- על פי תאוריית ההתקשרות תנאי מקדים לחקירה היא תחושה של בטחון. לכן המשימה הראשונה בטיפול היא דאגה לביסוס הברית הטיפולית, ויצירת ביטחון בקשר בין המטפל ובין ההורה, (הילד או המשפחה) תוך ויסות רגשי של תחושות החרדה והשימוש באסטרטגיות ההגנתיות המופעלות על ידה.

- מנקודת המבט של תאוריית ההתקשרות, תפקיד המטפל הוא להפוך ל"בסיס בטוח" ולא רק ל"נמל מבטחים". תפקיד זה מאפשר חקירה פנימית של רגשות, של השלכות ושל מוטיבציות של ההורה עצמו, ובשלב נוסף, גם אלה של הילד ושל היחסים עִמו.

התרומה של חשיבה במונחי התקשרות להתערבות

Connect before you redirect

היא מכוונת ליצירת **קשר בטוח ומותאם כולל תגובתיות המטפל.**

היצור האנושי זקוק לפידבק וזקוק לקשר. ניסוי ה"פנים הקפואות"- still face–מדגים זאת באופן דרמטי. (פידבק ועיבוד על בסיום פגישה)

היא עוזרת לנו לזהות את האסטרטגיות ההגנתיות שאדם מפעיל ביחס לצרכי ההתקשרות שלו (בטיפול וביחסיו עם ילדו) ובמיוחד את השימוש **בדי-אקטיבציה רגשית** (המנעות) לעומת **היפר-אקטיבציה רגשית** (שקיעה בחרדה) **ולעזור לוסת את החרדה ברמת חלון הסובלנות שלו.**

מאפשרת שימוש בידע על מכניזמים של שינוי ותיקון המאפשרים בחינה ובחירה מתוך טכניקות שבשימוש של הגישות הטיפוליות השונות בעיקר טכניקות המבוססות על **יכולת ההפעלה (ההטרמה) של זיכרון של דמויות מופנמות מיטיבות (priming).**

הצלחה בבחינה אחרי שרואים שם או תמונה של דמות התקשרות, פעילות מוחית שונה אחרי שרואים שם או את המילה אהבה ונכונות רבה יותר לעזור.

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

- The Still face experiment

משימות הטיפול בהורות

- בטיפול אנחנו משתדלים לספק חוויות של קבלה, אמון, בטחון ואמפטיה
- **דואגים להגדלת יכולת הויסות הרגשי**
- תומכים ומאתגרים **לחקירה ומנטליזציה** (Exploration vs. investigation) ביחס להורה עצמו, ביחס לילדו וליחסיהם, וגם ביחס לשעה הטיפולית **meta** (**processing**) .
- החקר כרוך בזיהוי **"פתחי כניסה" והתאמה לדפוסי ההתקשרות ולדפוסי החשיבה המופנמים של ההורה (רמה המודעות ההורית) .**
- מווסתים, מתחזקים מוטיבציה, ומזהים **אבני נגף רגשיות** ומקורות לחץ, ומנסים להקטין את האימפקט שלהם ולעבדם (רוחות רפאים וגם מלאכים בחדר הילדים, משברי חיים)
- מחפשים **מקורות חוסן, דרכי התמודדות חדשות, משפרים** מיומנויות ועוסקים בהתאמת פתרונות, מעודדים, מתנסים, ולומדים מהתנסויות

אסטרטגיות ויסות התקשרותי של הילד ושיפור ויסות רגשי של הילד באמצעות ההורים

- מתיאורי ההורים, או מן המפגשים של המטפל עם הילד, המשפחה או עם הדיאדה, יכול המטפל לזהות בהתנהגויות הבעייתיות של הילד גם את האסטרטגיות ההגנתיות ההתקשרותיות, שהילד מפעיל ביחסיו עם המבוגרים החשובים בחייו.
- הוא יכול לחלוק עם ההורים, בשפה מתאימה להם, את הזיהוי של האסטרטגיות הללו שהם בבסיס ההתנהגויות המקשות של הילד, לעזור להם לתת להן משמעות והבנה לגבי "למה הילד זקוק" ולעזור בחיפוש משותף של דרכים התנהגותיות למילוי הצורך.
- It's better to be wanted for murder than to feel not wanted at all

אלי אליהו- ולו לילה אחד

דָּבָר לֹא תִּזְכְּרִי מֵהַלַּיְלָה הַזֶּה.
לֹא אֶת עֲרִיסַת זְרוֹעוֹתַי
שֶׁנָּשְׂאָה אוֹתָךְ, כְּפִי
שֶׁהַקּוֹל נוֹשֵׂא אֶת הַהֵד,
לֹא אֶת הָעַקְשָׁנוּת
הָאִלֶּמֶת שֶׁל רַגְלַי שֶׁצָּעֲדוּ
עַל פְּנֵי הַחֶדֶר בִּדְבֵקוּת
שֶׁל מִתְאַבֵּד, לֹא אֶת אוֹר הַמְנוֹרָה
שֶׁנָּח עַל פָּנַיִךְ, וְלֹא אֶת לַחֲשֵׁי
הָאַהֲבָה שֶׁפִּנַּקְתִּי בְּאָזְנַיִךְ
עַד שֶׁנִּרְגַּעַתְּ וְנִרְדַּמְתְּ .
דָּבָר לֹא תִּזְכְּרִי מִכָּל זֶה.
אֲבָל מִכָּאן וְלִשְׁאֵרִית
חַיַּיִךְ, תְּבַקְּשִׁי
נֶפֶשׁ אַחַת
בָּעוֹלָם שֶׁתִּדְבַּק בָּךְ,
כְּפִי שֶׁאֲנִי
וְלוּ לְלַיְלָה אֶחָד

אמוציות בהורות

מערכת היחסים בין הורים לילדים מעוררת רגשות חזקים- חיוביים ושליליים. גם הורים במשפחות רגילות מדווחים כי הם חווים רמות גבוהות של כעס על ילדיהם, עליו הם צריכים להשתלט.

- במשפחות עם ילדים צעירים נמצא כי אינטראקציות קונפליקטואליות מתרחשות בין 3.5 ל-15 פעמים בשעה אחת.
- שכיחות זו גבוהה אף יותר במשפחות עם ילדים מוגבלים, חולים או תוקפניים.
- עם זאת מה שמייצב את היחסים היא העובדה שהורים במשפחות מתפקדות מדווחים על הרבה יותר אינטראקציות חיוביות עם ילדיהם לעומת שליליות (פי 2.5).
- אופי הביטוי, הניהול והתיקון של האמוציות ההוריות הן בבואה של בריאות היחסים בין ההורה והילד ושל התוצאה ההתפתחותית הצפוייה לילדים (Dix, 1991).

ויסות עצמי

- ויסות עצמי הוא הגיוס של יכולות פסיכו-ביולוגיות לצורך שמירה על הבטחון, השלמות, ההתפתחות, הרווחה והשגת המטרה של הפרט ושל קשריו המרכזיים (Ford, 2013)
- ויסות רגשי הוא תת-קטגוריה של ויסות עצמי , ומתייחס ליכולת לעצב (למנוע, לצפות ולהתאושש מ) אמוציות שליליים ולחוות רגשות חיוביים. הוא כרוך בניטור, תחזוקה ועיצוב של תגובות רגשיות באמצעים פנימיים וחיצוניים.
- וויסות רגשי אין משמעותו שליטה או איפוק רגשי, אלא הוא מצריך רכישה של מגוון אסטרטגיות,בחלקן כאלו המגבירות עוררות ולאו דווקא מפחיתות אותה, ויכולת הפעלה סלקטיבית ומתאימה שלהן.
- בכי, למשל, יכול להיות דרך טובה לפריקת רגשות קשים הנבנים ומצטברים ומחזיר את המערכת הסימפטית לאיזון על ידי הפעלת המערכת הפארא-סימפטית. השאלה נוגעת ליכולת לווסותו בהתאם למטרות הפרט.

מדדי ויסות רגשי:

- **קשיים בוויסות רגשי-DERS –מתבטאים בחוסר קבלה של תגובות רגשיות**, (כשאני מצוברחת, אני חשה אשמה על שאני מרגישה כך), **קושי להתחייב למטרה מכוונת** (כשאני מצוברחת, אני מתקשה לחשוב על דברים אחרים חוץ מהדבר שגרם לי לעצב), **קושי בשליטה על דחפים** (לא יכולה לשלוט במה שיוצא לי מהפה), **חוסר מודעות רגשי וחוסר בהירות רגשי** (אינני מרגיש כלום, או - אין לי מושג כיצד אני מרגישה), **זמינות מוגבלת של אסטרטגיות לוויסות רגשי** (אני חווה את רגשותיי כמציפים וחסרי שליטה).

- אסטרטגיות הויסות - נטייה לשימוש באחת משתי אסטרטגיות מרכזיות לוויסות הרגש (Gross & John, 2003): הערכה מחדש קוגניטיבית (cognitive reappraisal) ודיכוי ביטוי הרגש (expressive suppression). הערכה מחדש קשורה ביותר סימני הסתגלות והתמודדות מוצלחים ובבריאות, אם כי יש פעמים שדיכוי הבעת הרגש הוא חשוב ויעיל.

"איש אחד צעד בסופרמרקט מאחורי אמא וילדה בת שלוש, שישבה בתוך עגלת הקניות. כשהם עברו ליד מדף העוגיות, הילדה ביקשה עוגייה והאימא אמרה, "לא".

הילדה התחילה ליילל ולצעוק ולהקים מהומה, אבל האימא שמרה על שלוות רוחה ורק אמרה בנחת: "או- קי מוניקה, נשארו לנו רק עוד חצי שורת מדפים של עוגיות, תיכף נסיים כאן. אל תתרגזי, רק עוד טיפה".

הן סיימו את שורת העוגיות והמשיכו הלאה, תוך דקות הגיעו לשורת המדפים עמוסי הממתקים. הילדה החלה לצעוק ולדרוש ממתקים, האימא סירבה לקנות לה. הילדה התחילה לרקוע ברגליים ולהשתולל, אבל האימא לא איבדה את העשתונות: "די מוניקה, די אל תתרגזי, לא נשאר לנו עוד הרבה. עוד שתי שורות ואנחנו מסיימות את הקנייה. תהיי סבלנית. רק עוד טיפה".

כשהגיעו אל הקופה כדי לשלם עבור המצרכים, נתקל מבטה של הילדה במסטיקים הצבעוניים והיא דרשה בתוקף מסטיק. כשאמה השיבה בשלילה, עשתה שם הילדה סצנה קולנית של בכי וצעקות והאימא דיברה בקול רגוע ושקט: "מוניקה, לא להתרגז. אנחנו תיכף מסיימות כאן. חמש דקות ואנחנו בחוץ ואז ניסע הביתה ותוכלי לקבל את התנומה שאת כ"כ זקוקה לה".

האימא גמרה לשלם ויצאה מהסופרמרקט אל מכוניתה. האיש שהלך אחריהן והיה עד לכל המתרחש, יצא בעקבותיה, הדביק אותה במחצית הדרך לאוטו ואמר לה" תסלחי לי, גברתי, לא יכולתי שלא לשים לב כיצד שמרת על קור רוחך. אני חייב להחמיא לך על הדרך שבה התנהגת עם מוניקה הקטנה".

- נתנה בו האימא מבט מחויך ואמרה: " לקטנה הזו קוראים תמי. אני מוניקה".

- מוניקה מדגימה כיצד הורות כרוכה ברגשות עצמתיים, גם בשגרה של חיי יום-יום. היא מתגברת על תחושות חוסר אונים או בושה ומצליחה לא לקרוס לכיוון של כניעה לתביעות הילדה, וגם איננה נותנת לכעס להשתלט עליה לכיוון של התפרצות על הילדה. היא מספקת לילדה חוייה של הכלה ושעור במנטליזציה ובויסות עצמי, וגם ..מצליחה לעשות את הקניות...

ויסות עצמי וויסות-אחר

ויסות עצמי הוא תנאי מקדים ליכולת לעזור לאחר לווסת רגשות, תחושות, קשב, מוטיבציה והתנהגות ביחסי אנוש בכלל. ההורות מזמנת התמודדויות יוצאות דופן ומאתגרות של יכולת הויסות של ההורה: בגלל אופיין המכביד והמורכב של המטלות ההוריות, האמוציות החזקות המתעוררות בהורות, והשפעות הקונטקסט הבינאישי והתרבותי-חברתי בו הן מתרחשות.

חוסר ויסות הוא "מדבק":

התנהגות לא מווסתת של הילד עלולה להכניס בקלות את ההורה למצב דומה ולהגביר התנהגות לא מווסתת של הילד (ניסיון לא להרים את הקול שבוע- מתקלקל עבור האם כי הילדה שברה זאת) ;

חוסר ויסות אצל אחד מבני הזוג או גורם חיצוני (במערכת החינוך) נוטים להכניס את כל הנוגעים בדבר לחוסר ויסות*;

תופעות של אובדן ויסות אצל חברי משפחה מטופלת עלולים להכניס בקלות את המטפל לחוסר-ויסות*.

הדבר נכון אף יותר ומאתגר בטיפול בהורות לקויה.

הבנת תגובות הוריות
לחוסר ויסות רגשי אצל הילד

- כשהילד יוצא מויסות- בצורה מרדנית מתריסה או על ידי התעקשות המנעותית נוקשה הורים מנסים להשיג שליטה על המצב מתוך פיצול של "אני מול אתה" במקום "אנחנו בבעיה". נטייה לרדת לרמה של פעולות ולהמנע ממנטליזציה. אם ההורה מצליח לא להסחף ולהשאר מווסת הילד יצא מהר יותר מהמצב הדפנסיבי, יגיע פחות להתנהגויות קצה אימפולסיביות או של תקיעות.

הבדלים אינדיווידואליים ביכולות ויסות הוריות

יש לנו ידע מחקרי רב על התנהגויות ואפיונים הוריים המקדמים יכולות ויסות אצל הילדים- ומעט מאוד מחקר על התפתחות וחיזוק יכולות ויסות של הורים בתהליך ההורות.

נראה שיכולת ההורה להפעיל אמצעים לוויסות עצמי ולהשתמש בהם בהצלחה מושפעת מאינטראקציה בין שתי קבוצות גורמים-

-- השפעות קונטקסטואלית ובינאישיות:

אפיוני הילד עצמו, מערך הלחצים הפועלים על ההורה, כמו גם מערכות התמיכה העומדות לרשותו. מערך זה כולל מצבי-לחץ כרוניים (זמן) וזמניים הקשורים ביחסים זוגיים, משפחתיים, קהילתיים וגורמים סוציו-אקונומיים חברתיים ותרבותיים.

-- השפעות תוך-אישיות:

טמפרמנט ומבנה נוירולוגי, מחלות פיזיות ונפשיות, איכות ההתקשרות, חמלה עצמית, מצב רגשי, למידות מהעבר והעברות בינדוריות, ידע, תפיסות, דרכי חשיבה, ייחוסים ויכולות רפלקטיביות מטה-קוגניטיביות.

אמוציות בהורות

מערכת היחסים בין הורים לילדים מעוררת רגשות חזקים- חיוביים ושליליים. גם הורים במשפחות רגילות מדווחים כי הם חווים רמות גבוהות של כעס על ילדיהם, עליו הם צריכים להשתלט.

- במשפחות עם ילדים צעירים נמצא כי אינטראקציות קונפליקטואליות מתרחשות בין 3.5 ל-15 פעמים בשעה אחת.
- שכיחות זו גבוהה אף יותר במשפחות עם ילדים מוגבלים, חולים או תוקפניים.
- עם זאת מה שמייצב את היחסים היא העובדה שהורים במשפחות מתפקדות מדווחים על הרבה יותר אינטראקציות חיוביות עם ילדיהם לעומת שליליות (פי 2.5).
- אופי הביטוי, הניהול והתיקון של האמוציות ההוריות הן בבואה של בריאות היחסים בין ההורה והילד ושל התוצאה ההתפתחותית הצפוייה לילדים (Dix, 1991).

כיצד ניתן להשפיע על ויסות רגשי בהורות

- בסוס בטחון התקשרותי
- מנטליזציה
- חמלה עצמית
- רגשות חיוביים
- משחקיות
- ויסות פזיולוגי – חושי
- שותפת הורית
- EE הקטנת ביקורתיות ומעורבות יתר

ויסות רגשי ורגשות חיוביים

- **ויסות רגשי איננו רק הפחתה של רגשות אינטנסיביים והקלה של רגשות שליליים, אלא גם ההגדלה, החיזוק וההארכה של רגשות חיוביים**. יכולת זאת תורמת ליכולת ארגון עצמי מורכבת ויעילה יותר (Schore, 2003) . התערבויות מגישות שונות רלבנטיות למטרה זו:
- מדגישים את החיובי בדיווחיהם ובהתנהגותם של ההורים (דוגמת המודרך-האם המופתעת שזה הצליח).
- ידע על "ההטייה השלילית של המח" (Hanson, 2013). מסיבות אבולוציוניות המח האנושי מאורגן להבחין ולהתרשם יותר מהשלילי, ולהצפין במהירות בזכרון האימפליציטי חוויות יומיומיות של עצב, כעס, פחד, עצבנות, בעוד שזכרונות חיוביים יומיומיים לא מוחזקים מספיק זמן כדי להיות מוצפנים. יש למידת-יתר מחוויות שליליות ופחות מדי למידה מחוויות חיוביות. כאשר ידע זה על ההטיה השלילית של המוח נמסר להורים בבחינת מידע חינוכי־פסיכולוגי, הוא יכול לעזור להורים בתיקון ההטיות השליליות שלהם ובאיזון נקודת המבט על חומרת המצב. בשעת הטיפול אנחנו מאמצים את ההמלצות של הנסון להאט את הקצב כאשר עולה חוויה חיובית בשיח עם ההורים, ולדאוג להשתקעות בה, בגוף, וברשת האסוציאציות הרלבנטיות.

- מלאכים בחדר הילדים" ולא רק "רוחות רפאים" Lieberman et al., 2005

הגדלת רגשות חיוביים במשפחה

- ממליצים להורים להדגיש את החיובי במגעים עם הילד בפרופורציות של 1:5
- משחק "כל הכבוד" נעמי אפל
- מתן הזדמנויות לילד לתקן התנהגויות לא מתאימות (במקום ענישה) או להדגים שלמד "שיעור" תורם לשיקום היחסים, במיוחד אם זה נעשה בדרך משחקית ויצירתית ולא בפורמט קבוע הנחווה כמשפיל.

- **Priming (הטרמה)** אפשר לעודד את המטופל (הילד) להיזכר בדמות התקשרות בטוחה או בזיכרון של אינטראקציה מרגיעה עם מישהו למטרת ויסות מצוקה. הפעלה של ייצוגים של דמויות ההתקשרות סמלית או דמיונית, עוזרת לחיזוק תחושת הביטחון בנסיבות מלחיצות (Mikulincer & Shaver,2007).

הגברת רגשות שליליים ומאשימים מזינה רגשות שליליים אצל האחר

- אין טעם לשפוך שמן למדורה
- רדיו חזק איננו נשמע

ויסות רגשי על ידי העצמת רגשות חיוביים, משחק ומשחקיות

המטפל עצמו משמש מודל למשחקיות בשימוש שלו בתקשורת סימבולית (שימוש במטפורות ובפתגמים, התבדחות על עצמו ועל המצב) כדי לווסת את האווירה הטיפולית ולחלץ מתקיעות. המטפל מעודד את ההורה למצוא עיסוק וזמן איכות עם הילד שייהנו אותו ואת הילד ומשתמש במשחק בפגישות עם הילד והמשפחה ("ילדים נאים").

Filial Therapy

"לבקר אחרים, ולתת להם את ההרגשה שאינם רצויים –
זאת יכול כל אחד לעשות.
אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה –
לכך דרושים כשרון מיוחד והשקעת מאמץ"
(רבי נחמן מברסלב).

מהי משחקיות?

משחקיות מתייחסת להתנהגות ספונטנית פיזית, קוגניטיבית וחברתית שמביעה שמחה, הומור, סקרנות, דמיון ויצירתיות.

אלן שור (2003) מדגיש שויסות רגשי איננו רק הפחתה של רגשות אינטנסיביים והקלה של רגשות שליליים, אלא גם ההגדלה, החיזוק וההארכה של רגשות חיוביים. יכולת זו תורמת ליכולות ארגון עצמי מורכבת ויעילה יותר.

היא הופכת לאפיון של היחיד. ואכן מוצאים כי בבגרות- יכולת ההפעלה של משחקיות מסייעת להסתגלות במצבי לחץ (Fredrickson, 2000).

משחקיות- צורך מולד הזקוק לתמיכה הורית

- Trevarthen, טוענת שלתינוק צורך בסיסי ב joyful--dialogic companionship, הכולל חיות, סמיכות, רתמיות ואפקט חיובי.
- בתחום מדעי המח נתגלתה בשנים האחרונות מערכת המשחק--משחקיות כמערכת המחוייטת במח של היונקים, ונמצא כי אינטראקציות משחקיות מוקדמות מגרות הפרשות של אופואידים ודופמין המנטרלים כאב ומצוקה ומקדמים תחושות הנאה; נכנסים לאזורים הפריפרונטליים ומחזקים מעגלים במח של פונקציות אקזקוטיביות הקשורים בויסות (Panksepp, 2009).

משחק ומשחקיות

משחקיות מתפתחת בהקשר של יחסי הורה-ילד מוקדמים, ובעצם משמשת את ההורים כמכניזם מרכזי לויסות רגשי. היא כוללת אינטראקציה הדדית הכוללת מרכיבים לא מילוליים של הבעות פנים, קשר-עין, דיאלוגים טרום-מילוליים, נגיעות, תנועות לקצב, שינויי מנח גוף, שמטרתם **שותפות בחוייה אינטרסובייקטיבית של הנאה מהפעילות המשותפת ומהשני.**

- זה מאפשר פיתוח אסטרטגיות משותפות (קודים) ושיתוף במשמעויות, המקדמות את היכולת למשחק דמיוני. משחק חפשי דורש "קריאת אנשים" וויסות רגשי כדי שההדדיות במשחק תמשך.
- משחק מאפשר לילד ולהורה המשתתף לשמור במיינד יותר מפרספקטיבה אחת בו-זמנית (פונגי ושות'; Lyons-Ruth, 2006)
- כל אלה תורמים ליכולת הילד למנטליזציה, לויסות רגשות והתנהגות בינאישית ולעיבוד חויות טראומטיות

נעשה מקום למשחק (נמ"ל)

- ויניקוט הדגיש בזמנו כי היכולת לשחק, כלומר לקיים את חוויית האשליה הנדרשת כדי לקיים את המפגש בין הדמיון והמציאות תלוי בדרך התייחסות הסביבה הקרובה למשחק ולאביזריו
- השיפור בתפקוד הקוגניטיבי, החברתי והרגשי של ילדים שהוריהם מעורבים עימם בפעילות משחקית איננו מבוסס רק על מרכיב המעורבות ההורית, אלא שלעצם פעילות המשחק עם ההורים יש משקל מרכזי בשיפור, בהשוואה לפעילויות משותפות אחרות, במדדים: גילוי רגשות חיוביים, אינטראקציה חברתית, שיתוף פעולה, יכולת ריכוז, שטף מילולי, גמישות, יצירתיות, ואף IQ (Singer &Singer, 1996)
- הורים רבים אינם מבינים את ערך המשחק הדמיוני להתפתחות, מרגישים מאויימים או לא בנוח איתו ומפנים ילדים לשחק לבד או עם חברים.
- אמהות "מה זה"; דוגמת אם לתאומים
-

משחקיות בהתערבויות טיפוליות

- העקרון של "משחקיות" משדר למשפחה שהחוויות הקשות שהם חווים הם רק חלק מהתמונה הכוללת של היחסים שלהם ושיש יותר מדרך אחת לחוות את האירוע בו הם עסוקים. עמדה של "משחקיות" מפחיתה בושה וחרדה ומאפשרת לעבור לרגשות חיוביים מתוך רגשות קשים ביתר קלות מאשר מעבר ישיר לרגשות חיבה ואיכפתיות. דבור משתעשע בין מבוגר וילד יוצר חווייה מהנה ומגביר את היצירתיות.
- ההכנסה של משחק ומשחקיות לתוך טיפול היא לכן חלק חשוב של בניית ויסות עצמי וויסות הדדי ותורמת לחילוץ מתיעות ושיפור טיפולי.
- ממצאים מתכנית נמ"ל –המבוססת על מסרים "משחקיים" (פתגמים) ופעילויות דיאדיות של הנאה משותפת אם-ילד:
- ירידה בבעיות ההתנהגות של הילדים, עלייה בתחושת המסוגלות ההורית, עליה בזמינות רגשית אצל האם ובמשחקיות אצל הילד.

משחקיות ו- care-giving

- משחקיות- מקדמת את מערכת ההתקרבות והתגמול ההורית
Hughes, D.A. & Baylin, J. (2012). Brain –based parenting. Norton

(יש להזהר לא להשתמש במשחקיות כדי להקטין את הבעיות שההורה מציג או לברוח מרגשות).

- היכולת לשחק עם ילד מחזקת את יכולת ההורה להתמודד עם אספקטים לא משחקיים בקשר הדורשים מההורה הרבה שליטה-עצמית וסובלנות.
- משחק פותח אפשרויות ומעורר תקווה, מאפשר להכיר את הילד מזוית אחרת, לראות דברים בפרספקטיבה, וברפלקציה, כמו במיינדפולנס.

ויסות-עצמי ויכולות מטה-קוגניטיביות

" יכולת רפלקטיבית או מנטליזציה" יכולת מטה-קוגניטיבית המאפשרת לפרט להרהר בהתנהגותו שלו, כמו גם בהתנהגותם של אחרים - במונחים של הרגשות, מוטיבציות, תפיסות וסיבות סובייקטיביות – ולהבינם (Fonagy). יכולת זו מאפשרת להחזיק בו זמנית מציאות פנימית ומציאות חיצונית, מציאות שלי ושל האחר. יכולת זו נותנת משמעות להתנהגות ולהתרחשויות, ועושה את העולם ליותר מובן, ניתן לניבוי ולהתמודדות אדפטיבית. ליכולת זו יש משמעות קריטית ביצירת אישיות מווסתת. פגיעה ביכולת זו קשורה להתנהגות המאופיינת בחוסר ויסות והתפרצויות ולהתפתחות של הפרעת אישיות גבולית.

יכולת זו נרכשת באמצעות יחסי הורה-ילד מוקדמים שבהם ההורה מסוגל להיות אמפטי, מארגן ותגובתי לרגשות וחוויות התינוק ובו-זמנית מסומן כ"אחר". ניתן לפתח יכולת זו גם בבגרות.

קוגניציות, יכולות מטה-קוגניטיביות וויסות עצמי בהורות

- במחקר מוצאים קשר משמעותי בין יכולות ויסות רגשי והתנהגותי ביחסי ההורה עם הילד לבין קוגניציות והערכות הוריות. כך למשל:
- הורים החשים מצוקה ביחסיהם עם ילדיהם מחזיקים בציפיות גבוהות יותר מילדיהם, מעריכים את כוונות הילד בצורה שלילית יותר ואת האפקטיביות שלהם כהורים כפחותה יותר, זאת בהשוואה להורים המצליחים לנהל יחסים הרמוניים יותר עם ילדיהם.
- הורים מתעללים ומזניחים מתקשים להבין מורכבות של יחסים בינאישיים ולראות את הילד כפרט. הם מוגבלים ביכולת לזהות מצבי רגש, להבין את מקורם ומתקשים להעריך מה תהיה התוצאה של ביטוי הרגשות ביחסים עם האחר.

התקשרות ומנטליציה -קשר הדדי

"mentalizing begets mentalizing"

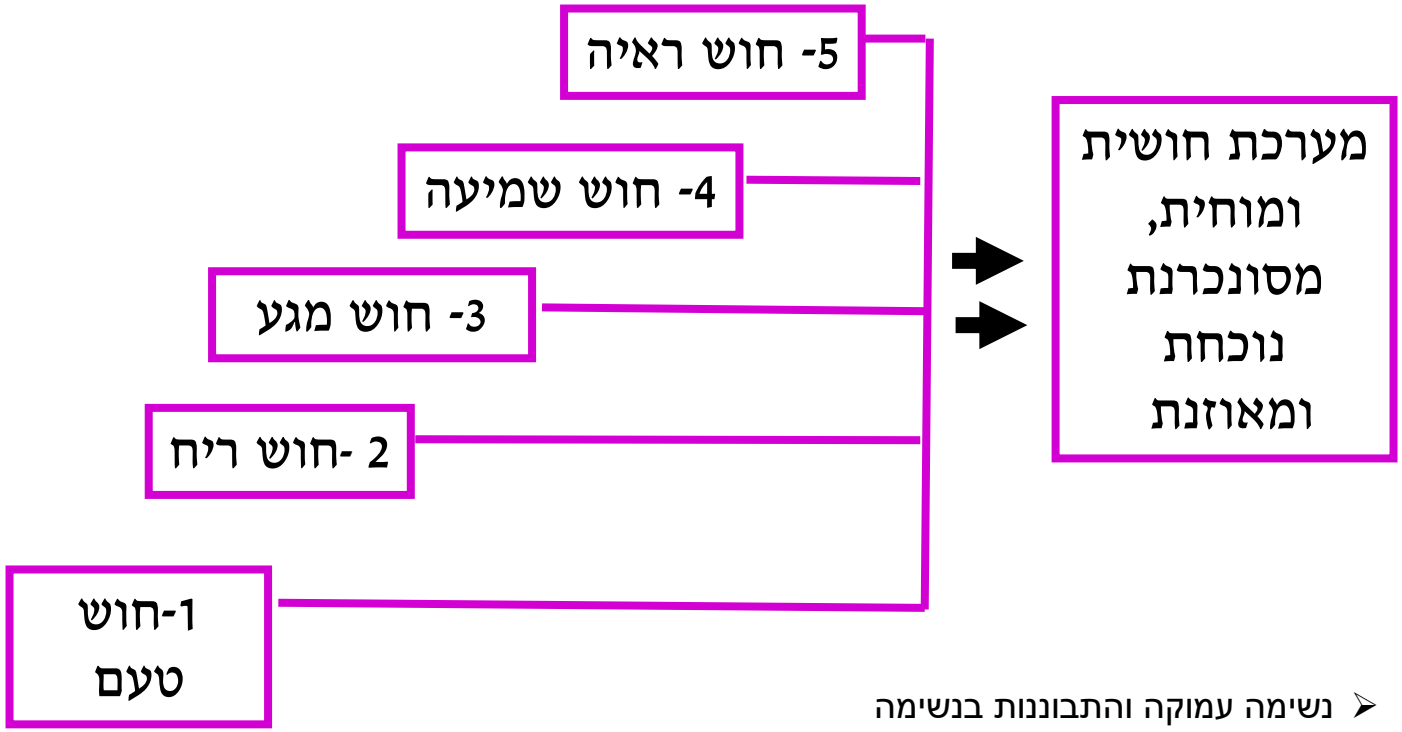
- מנטליזציה היא הדבק של קשרי התקשרות בטוחים. בעזרת מנטליזציה זוכה הפרט ל"נראות", לתיקוף רגשי ולהערכה שהיו חסרים לו בילדותו, ובעזרתה הוא יכול לשקם את איכות ההתקשרות שלו. התקשרות בטוחה מאפשרת מנטליזציה.
- הובלת תהליך המנטליזציה של ההורה בטיפול בהורות וגם בטיפול בילד, היא משימה מרכזית של המטפל. הוא מגייס בתחקור שלו הרחבה של עולם ההשערות של המטופל אשר לגורמים שבבסיס התנהגותו שלו, וגם של ילדו. הוא תורם ידע, מציע אפשרויות חשיבה אלטרנטיביות, ומשתמש בדוגמאות כדי לגרות אינטרפרטציות שונות של אותו מצב, וכדי לאפשר למטופל הסתכלות מורכבת יותר על התנהגות ועל יחסים.
- *אם למטפלת לקראת סוף טיפול, בתארה קונפליקט עם הילד: "לקחתי רגע לחשוב מה את היית שואלת אותי בשיחה על התקרית, ועניתי לעצמי, וכבר הייתי במקום אחר מבחינה רגשית, והיה לי ברור מה אני רוצה לעשות.*

BELLY BREATH – ויסות רגשי פיזיולוגי

- http://www.youtube.com/watch?v=_mZbzDOpylA

מדיטציית קשיבות – 5 החושים בחמישה שלבים

- נשימה עמוקה והתבוננות בנשימה



- נשימה עמוקה והתבוננות בנשימה

הצהרת כוונות להורות בקשיבות

- אני מעוניין ביחסי הורה-ילד בריאים יותר. אני משקיע משאבים כדי להיות הורה קשוב, וזאת, על מנת לחזק את עצמי ואת הילד שלי ומתוך כך את הקשר בינינו.
- אני יכול להיות 'הורה קשוב והורה בוחר בכוונה תחילה'.

משמעותו:

- אני מעוניין להבין טוב יותר מדוע אני מתנהג בדרך מסוימת ורוצה שתהיה לי אפשרות לבחור באיזו דרך להתנהג ולהתנהל, על מנת לבנות קשר יותר בטוח עם הילד שלי.
- לשם כך, אני מעוניין ללמוד לשים לב לדפוסים של עצמי, לדרכי החשיבה שלי, לתגובות הרגשיות שלי ולהתנהגות שלי.
- ארחיב את היכולת שלי להבין ואת היכולת שלי להגיב בצורה יותר יעילה.
- שינוי הוא אפשרי מתוך קבלה = דיאלקטיקה.
- הוא מותנה ב:
- תירגול בקביעות של מודעות עצמית, הבנה עצמית וקבלה עצמית.
- מאמץ והשתדלות אינסופיים לתרגל: אפס מאבק, אפס שיפוטיות ואפס ביקורת, כלפי עצמי וכלפי בני משפחתי מתוך גמישות וחיוביות בתגובותיי לעצמי ולאחרים.

הצטרפות ואתגור

joining and challenging

- עמדות טיפוליות בסיסיות הלקוחות מן הגישה המבנית והאסטרטגית לטיפול משפחתי, שמטרתן לייצר שינוי בדפוסים משפחתיים מתוך עמדה המכירה בכוחות המשפחה ומשאביה (Minuchin & Colapinto 1991)

מתאים להתייחסות לפקיד הכפול של ההורה - הוא גם מטופל וגם מטפל/סוכן שינוי בקשיי ילדו.

- הצטרפות- היכולת לתת למטופל תחושה שהמטפל מבין אותו, עובד יחד עמו ולמענו, מכבד ומקבל אותו, מבין את צרכיו ומטרותיו, ואמפטי לרגשותיו.
- אתגור- היכולת של המטפל להישאר נפרד מן המטופל, תוך ניסיון אמפאתי וסקרן, להתבונן ולתהות עם המטופל על צדדים שונים של עצמו, של "אחר" ושל המציאות. המטפל אינו מקבל כמובן מאליו את הנחות המטופל ותפיסותיו, אלא מביא את אלו להסתכלות חשיבה והתנסות משותפת. הוא גם משתמש בידע ובניסיון שלו לצורך האתגור.

אתגור בתוך חלון הסובלנות הרגשי
window of tolerance (Siegel, 1999)

- הערנות להגנות המופעלות במצבים של פגיעות, מאפשרת למטפל בהורים לעבוד ב"רמת הסובלנות" המתאימה להורה. הדבר נכון גם למטפל בילד ובדיאדה.
- האתגור נעשה במסגרת "חלון הסובלנות" של המטופל בכוונה לשמירה בטיפול על הוויסות הרגשי, כך שהמטופל ירגיש פיזית ורגשית שהוא מסוגל לעסוק במשימה שלשמה נפגשים. לחלון הסובלנות של כל פרט יש גבול עליון המתבטא בעוררות יתר וגבול תחתון המתבטא בתת־עוררות.
- היכרות של המטפל וגם של המטופל עם המצבים שבהם המטופל עלול לעבור את גבולות הסובלנות שלו, וזיהוי רגעים אלה כשהם מתרחשים, חשובים ביותר ביחסי מטפל־מטופל, ביחסים בין שני ההורים בפגישה הטיפולית ובהתמודדות של הילד בחיי יום-יום.

.

התהליך הטיפולי

- יצירת קשר בטוח, נענה ואמפטי
- ניטור ועזרה בויסות רגשי תוך שימוש בטכניקות לויסות רמת העוררות והלחץ בפגישה הטיפולית ומחוצה לה. זאת תוך התאמת סגנון ההתערבות לסוג הויסות ההגנתי של ההורה (תת-ויסות; ויסות-יתר, חוסר ארגון): ארגון החשיבה, ויסות פזיולוגי, מתן ידע, הצבת גבולות, אופטימיות. תמיכה במטרות הוריות והתחשבות בנקודות תורפה וחסכים.
- חקירה וקידום "יכולת מנטליזציה" ע"י ניהול "דיאלוג רפלקטיבי" מכבד ומאתגר.
- הצטרפות ואתגור של תפיסות, רגשות והתנהגות המבוסס על זיהוי דפוסי החשיבה ההוריים הצטרפות אליהם והצבת פיגומים כדי להגמישם ולהרחיבם בהדרגה. כלי עזר בתהליך זה: זיהוי וקידום "רמת מודעות הורית".
- תכנון שינוי בשלבים ובתהליך סבלני מן המקום בו ההורה נמצא אל עבר מטרה משמעותית וריאלית בקשר שלו עם הילד תוך הצבת פיגומים.

מהלך הטיפול ומשימותיו

1. יצירה ותחזוקה של הברית הטיפולית ושל ויסות רגשי (כולל זיהוי מטרות הוריות, כוחות ואזורי פגיעות)-**שיום**, קבלה והכלה
2. חקירה ועיבוד- חקירה וחידוד הבנות לגבי המטרות ומשמעות התנהגותם; בדיקת ציפיות, התאמתם ומקורותיהם, בדיקת הבנות לגבי הילד משמעות והשלכות והדינמיקה של מערכת היחסים איתו (העמקה, תיקוף, הצטרפות ומיקוד ראשוני)
3. הנעת תהליך שינוי – **הצטרפות ואתגור** בהתחשב *ב-confirmation bias באמצעות **מיסגור מחדש התייחסותי** (מערב יחסים בין מספר אנשים, בלתי מאשים, משרה תקווה ופותח אפשרויות), שיח **אפקטיבי רפלקטיבי** לגבי הבנות וציפיות, עקרונות **תקשורת רגישה ויעילה,** בהתאם **לרמת המודעות**, בנית **נרטיב קוהרנטי** והסכמה למוקד ולתהליך השינוי
4. יישום: דפוסי יחסים חדשים, תהליכי פתרון בעיות, התנסות ותיקון.
5. סיום

- Tali Sharot (2017) The influential mind: What the brain reveals about our power to change others. (utube)

תפקיד המטפל בזיהוי ושיום תחושות ורגשות

- מחקרים מראים כי עצם השיום של רגש ושל חווייה – עוזר להתמודד איתה.(ניסוי הטרנטולה).
- כשהקרובים לנו אינם מגיבים לעולמנו הפנימי קשה לנו ללמוד מילים כדי לדבר על החווייה שלנו. העולם הפנימי מקבל איכות מעורפלת וחסרת ביטוי. חוויות סובייקטיביות ממשיכות להתרחש אבל קשה להבין אותם או לתקשר לגביהן.
- **הילדים או ההורים שאינם מגיבים לתחקור שלנו אינם נמנעים בכוונה,** הם באמת אינם יודעים כיצד לתאר את רגשותיהם ומחשבותיהם. תחושת העצמי שלהם חסרה קוהרנטיות, המשכיות, בהירות והבנה.(יוז)
- **תפקיד המטפל לשיים או לנסות לנחש את רגשות ההורים (או הילד) לעבור לרמה של תחושות במקום רגשות, ולעודד גילוי רגשות אישי וניחושים לגבי איך אחרים מרגישים במצב זה.**

Reframing- מסגור מחדש התייחסותי

- **מסגור מחדש** היא טכניקה טיפולית המסייעת לפרט להסתכל במצב, על אדם או קשר על ידי שינוי המשמעות שלו ("עקשן" = בעל יכולת התמדה; "חרדתי"= זהיר ומחושב) הילד הבעייתי כמנסה לעזור להורים כדי למנוע עליית הקונפליקט ביניהם ולקרבם)
- מסגור מחדש התייחסותי הגדרה מחודשת של הבעייה המערבת יחסים בין מספר אנשים. ההגדרה כוללת הבנה לא מאשימה, משרה תקווה ופותח אפשרויות. אין שינוי של העובדות ושל תוצאות ההתנהגות – וצער על כך ש"כוונות טובות לעתים מובילות לגיהינום"

- אב שסוגר את המים כשהאם מקלחת את הילדים.

המטפל כמנטלייזור של התנהגות הילד עבור ההורה ושל התנהגות ההורה עבור הילד

- אליסיה ליברמן CPP- הדגמה של **רפריימינג** חיובי של מוטיבציה של ההורה עבור הילד ושל המוטיבציה של הילד עבור ההורה
- בסוף פגישה דיאדית עם אם שסבלה מאלימות בעלה וילדה בת שנתיים, הילדה מסרבת לסדר את החדר. האם עוצרת בחריפות את המטפלת שמתחילה לעזור לילדה ואומרת "הילדה חייבת ללמוד לסדר לבד, היא משאירה את החדר בבלגן ואני לא יכולה תמיד לעזור לה". המטפלת מתגברת על הכעס שלה על האם התובענית ונזכרת בעייפות ובלחץ של האם. פונה לילדה ואומרת לה "אמא מנסה ללמד אותך משהו מאוד חשוב. היא רוצה שתדאי לשמור על הצעצועים כך שתוכלי למצוא אותם כשתחזרי. קשה לך לסדר כי את לא רוצה עדיין ללכת, אבל כל הצעצועים יהיו פה במקום שתשימי כשתחזרי". אחרי ששתיהן חוזרות שוב על דבריהן הילדה מסדרת ושתיהן מוחות כפיים. האם אומרת למטפלת לפני העזיבה "לא חשבתי שאני מלמדת אותה משהו. פשוט רציתי שתעשה מה שאני אומרת". המטפלת עונה בחיוך "הנה, לא ידעת אפילו שאת מורה". האם ממשיכה "אני לא חושבת שהיא ממש הבינה מה שאמרת לה". המטפלת מרגישה את התחרותיות של האם ואומרת "את צודקת, אבל אני מאמינה שהיא הרגישה שאנחנו מנסות לעזור לה"...

Hughes 2007– דיאלוג אפקטיבי רפלקטיבי -

- המטפל יוצר דיאלוג אפקטיבי-רפלקטיבי עם ההורה, הכולל מרחב בטוח לשיתוף ברגשות וכוונות של ההורה, ועיסוק אקטיבי בהבנה של ההורה את עצמו, את הרגשות והמחשבות העומדות מאחורי התנהגותו. אמפטיה מאפשרת חקירה והחקירה מגדילה אמפטיה והבנה קוהרנטית (עוזרת להפוך את הלא-עקבי לעקבי והלא-המשכי להמשכי).
- בהמשך המטפל מכוון את ההורה לחקירה דומה של התנהגות הילד והקשר בינו לבין הילד. ההנחה היא שבהמשך יוכל ההורה לנהל דיאלוגים מסוג זה עם ילדו
- המטפל עושה מודלינג של עמדה רפלקטיבית ביחס להורה וביחס לילד, על ידי שמקדם תהייה וסקרנות לגבי חוויות העומדות מאחורי התנהגויות הן של הילד והן של ההורה באינטרקאציה ההדדית. חשוב לזכור שהן **נשאלות פחות עם הציפיה שלהורה יש תשובה** לשאלות אלה או שהוא מחזיק בהן, אלא כדי לעורר רפלקציה משותפת לגבי הילד

חקירה- שאלות לדוגמא לפתוח דיאלוג אפקטיבי רפלקטיבי –

- כיצד את מרגישה כש...?
- כיצד את מתמודדת כאשר..?
- מה את עושה כשאת חושבת ש...?
- האם זה קרה בהזדמנות אחרת או עם מישהו אחר?
- האם זה משפיע על מה שאת חושבת/מרגישה/ רוצה?
- האם יש מצבים אחרים שאת מרגישה/חושבת /רוצה כך?
- **איך את מרגישה לדבר על זה עמי?**
- האם לעיתים את חשה אחרת במצבים כאלו?
- מה מאפשר לך לחוש/לחשוב/ לרצות משהו אחר?
- מה תחשבי/תרצי/תרגישי אם...?
- מתי הפעם הראשונה שחשת/חשבת כך
- למה אתה חושב שהוא אמר ....?
- מה המשמעות של זה שאת/היא אומרת/עושה כך...?

תגובה רגישה ויעילה עם הורה במצבי לחץ וקונפליקט (כהן 2014)

- 1.זיהוי הרגש, המוטיבציה, הצורך של ההורה וקבלתו באופן אמפטי.

העקרון של קבלה, משמעותו שהמטפל איננו מנסה לשנות אף אחד מבני המשפחה אלא לקבל את המצב הרגשי של כל אחד, להצטרף לקצב שלו, ולהתעניין באופן סקרני במשמעות החווייה לעומקה. המטפל מביע קבלה של כל רגש, מחשבה, פנטזיה וכוונה, אך לא של כל מעשה. באמצעות הקבלה והברור המעמיק של החווייה הוא עוזר לווסת מצב רגשי קשה, כי מפחית את הבושה והקושי של המטופל עצמו לחיות עם החוויות הרגשיות הללו בנרטיב שלו.

- 2. חקירה ותיקוף של הרגש (לאור ההיסטוריה של ההורה, הפגיעות שלו, לחצי חייו הנוכחיים, מטרותיו ודאגותיו)
- 3. אתגור דרכי ההתמודדות עם השגת הצרכים של ההורה (לאור נתוני הילד, נסיבות, תרבות, ידע, ההבנה של הילד והייצוג שלו, הבנת הדינמיקה המשפחתית)
- 4. פתיחת מרחב לשינוי ציפיות הוריות ו/או שינוי התנהגויות הוריות.

- למשל הורה שמתפרץ בצורה פוגענית כלפי ילדו ו....

אני מבינה שכאשר יוסי מתנהג כך כלפי אחותו אתה חש חסר אונים כי כל מה שאמרת ביקשת ולימדת נפרץ ויוסי לא משתלט על עצמו. כשאתה מרגיש חסר אונים אתה חושש מהרע מכל, וזה מזכיר לך כיצד אתה חשת כאשר בריונים הציקו לך בתיכון, ואתה מרגיש שאתה חייב להגן על בתך בכל מחיר.

אולם כאשר אתה מרביץ ליוסי הוא לומד בדיוק משהו אחר ממה שחשוב לך שהוא ילמד, הוא לומד שכאשר מרגישים חוסר אונים ונראה שאין פתרון מותר להרביץ. אני מציעה שנחשוב כאן ביחד על דרכים בהם תוכל לעזור ליוסי לא להתנהג כך כלפי אחותו ולא תגיע למצב שאתה נוהג בדרך שבעצם את פוסל ולא מעונין בה.

ציפיות הוריות, יכולות הוריות והעברה בינדורית

- סגירת הפער בין הדימוי והמציאות או החוויה (Galinsky (-Between generation
- חמלה עצמית
- הרצון להיות ההורה האידיאלי-
- הרצון לילד האידיאלי-
- לעזור לכל אחד מהמטופלים לטוות **נרטיב משמעותי**. נרטיב משמעותי הוא כזה שמצליח לשלב רגש וקוגניציה; הבנות אמפטיות לגבי עצמו ולגבי ה"אחר"; מתבסס על ספור אוטוביוגרפי קוהרנטי שאיננו מקוטע או סובל מהשמטות הגנתיות.
- צרוף חווייה חיובית בטיפול עם השלילית, והשהייה של המודעות לתחושות
- או להוסיף בדמיון לחווייה הנוכחית ולמה שלא קרה את מה שהיה צריך לקרות בעבר הרחוק או הקרוב

תגובה רגישה ויעילה עם ילדים במצבי קונפליקט

1. זיהוי הרגש או המוטיבציה שבבסיס התנהגות הילד 2. חקירה ותיקוף מקורות הרגש בדרך כלל ילדים משייכים להורה מניעים של דחיה, ביקורת או חוסר איכפתיות, ולעצמם מניעים של בושה ופגיעות.
3. הבהרה של עמדת ההורה, רגשותיו
4. יצירת מרחב להדברות ולגישור בין צרכי ההורה וצרכי הילד

חשיבות התרגול גם כאשר ההורה לא מגוייס רגשית.

- **לדוגמא**: הפרעת לי בשיחת הטלפון כי היה לך קשה להמתין לכך שאקשיב לך.
- כשמשהו מרגיש מאד דחוף ונרגשים- קשה להמתין.
- אבל אני רוצה שתדעי שזה מאד מעצבן אותי כשאת מפריעה לי באמצע שיחה חשובה לי. אינני מוכנה שזה יקרה שוב.
- אולי נקבע סימן כדי שאדע מתי לקצר מאד בשיחה, כי יש לך משהו חשוב שאת צריכה לדבר עליו, ואני אשתדל מאד להתפנות אלייך מהר.

התמודדות הורים עם מצבי מתח וקונפליקט עם ילדם

כהן ועופר זיו 2007

בחירת דרך ההתמודדות מבוססת על

- א. הבנות של התנהגות ההורה, הילד והקשר ביניהם
- ב. בחירת תגובות התנהגותיות הוריות הלוקחות בחשבון את שני הצדדים

קיימים מספר דגמי התמודדות הורית עם מצבי מתח וקונפליקט עם ילדיהם:

- **תגובות פעולה**: ההורה מחליט על פתרון הקונפליקט על ידי:
  - קבלה/כניעה של ההורה לרצון הילד
  - פשרה הלוקחת בחשבון את רצונות שני הצדדים
- **תגובות פרשניות** המפתחות יכולת הילד לתת משמעות להתנהגות של עצמו ושל אחרים: ההורה מפרש את הילד, ההורה מפרש לילד את עצמו, ההורה מפרש לילד את האינטראקציה, ההורה מפרש לילד התנהגות של אחרים
- חשיבות האיזון והמגוון בדרכי התמודדות עם קונפליקטים להתפתחות הילד
- השהייה והחזקת הקונפליקט עד שצץ רעיון יצירתי (לא להכות בברזל בעודו חם)

רמת-מודעות הורית כהן 1996,2006,2014
Parental level of awareness

- הגדרה- מדד איכותי של רמת המורכבות של החשיבה ההורית הטיפוסית בסוגיות הנוגעות להבנת הילד והתנהגותו ולתפיסת תפקיד ההורה. מורכבות זו קשורה למערכת אמונות, ידע ודרכי חשיבה. אלה מופעלות במיוחד כאשר ההורה צריך להגיב להתנהגות הילד או לקבל החלטות ביחס אליו.
- **רמת מודעות הורית (Cohen, 2004, 2006)**-מושג המתייחס למורכבות המערכת של שיקולי הדעת שמפעיל ההורה, כאשר הוא מנסה להבין את ילדו ולהחליט החלטות הוריות. ההנחה היא כי רמת מודעות מורכבת יותר, מאפשרת גמישות רבה יותר בהבנה של בעיית הילד ובמציאת פתרונות יצירתיים ומגוונים יותר

- המדד איננו מתייחס לתוכן של עמדות ותפיסות הוריות או למידת הרציות של החלטות ספציפיות, אלא למורכבות תהליך החשיבה שהוביל לקבלת ההחלטה או לתגובה.
- הנחת הבסיס הינה שחשיבה מורכבת יותר הכוללת רפלקציה והסתכלות ממספר פרספקטיבות מאפשרת ויסות רגשי, ובעקבותיו יותר קבלה, גמישות ויצירתיות בפתרון בעיות בינאישיות.

- במחקר נמצא כי רמת מודעות נמוכה מהווה גורם סיכון בהורות בעיתות לחץ.
- רמת המורכבות נקבעת על ידי התעניינות ותשאול לגבי הסיבות לקבלת החלטה או תגובה ושיוך לאחת מ- 4 רמות מודעות הורית. כל רמה כוללת את הרמות הקודמות אך מוסיפה פרספקטיבה שונה מהן איכותית. השלבים מהווים רצף של שלבים התפתחותיים.

עקרונות התערבות על בסיס רמת המודעות ההורית כהן 2014

המשגת רמת המודעות ההורית מאפשרת למטפל לווסת ציפיות ולראות את ההורה בפרספקטיבה התפתחותית במקום שיפוטית ודטרמיניסטית

המשגה זו תורמת ליכולת המטפל לקבל את ההורה במקום בו הוא נמצא עם "מפת דרך" לגבי מסלול ההתקדמות הריאלי אל השלב הבא על ידי:

- הצטרפות לרמת המודעות הנוכחית של ההורה והבעת הבנה קבלה ואמפטיה לרגשות וצרכים הוריים (לא להתנהגויות) וכבוד או הבנה לאמונות ודרכי חשיבה שלו.
- הרחבת המורכבות החשיבתית על ידי :דיאלוגים רפלקטיביים באמצעות הארת אינפורמציה חדשה וטיעונים נוספים מאותה רמת מודעות או הצבת פיגומים (Scaffolding - ויגוצקי) לקראת הרמה הבאה מבחינה התפתחותית.
- חקירה ועיבוד של הנרטיב האישי של ההורה, של הילד ושל מערכת היחסים ביניהם

דוגמאות לשאלות היכולות לעזור לאבחון רמת מודעות הורית

תארי לי את הילד שלך, איזה מין ילד הוא?
ממה את נהנית ממנו במיוחד, מדוע?
מה קשה לך בהורות איתו, מדוע? מה מדאיג?
בכל משפחה יש צורך לעתים להתמודד עם כך שילדים אינם רוצים לעשות דברים מסוימים שהכרחי שיעשו. כיצד אתם מתמודדים עם מצבים כאלה?
מדוע בחרתם בדרך זו?
מה סדר היום של הילד, כיצד הוא נקבע, מדוע?
האם אתה מתערב בהכנת השעורים של הילד, באיזה אופן, מדוע?
מה מידת וצורת המעורבות שלך בחיי החברה של ילדכם? מדוע?
כיצד אתם מבינים את הבעיה שבגללה אתם פונים לעזרה? אנא הסבירו
האם וכיצד היא עשויה להיפתר? מדוע?
מה כבר עשיתם לפתרון הבעיה? כיצד התקבלה ההחלטה לנקוט בדרך זו?
האם זה הצליח? מדוע?
מה ה"כוחות", (היכולות) שאתם מביאים אתכם להתמודדות עם בעיית הילד, ולאילו רגישויות ונקודות תורפה יש לשים לב ולהביא בחשבון? מדוע?
- חשוב: בסוף כל שאלה לשאול מדוע, לבקש דוגמאות, לבקש פרוט , הסבר והכוונה שמאחורי המעשה או ההחלטה.

עקרונות התערבות על בסיס רמת המודעות

- המשגת רמת המודעות ההורית מאפשרת למטפל לווסת ציפיות ולראות את ההורה בפרספקטיבה התפתחותית במקום שיפוטית ודטרמיניסטית (כלומר להחזיק בו זמנית בראש את ההורה "המצופה" מבחינת הילד ואת ההורה מבחינת התפתחותו שלו).
- זה מגדיל את היכולת לקבל את ההורה במקום בו הוא נמצא עם "מפת דרך" לגבי מסלול ההתקדמות הריאלי אל השלב הבא על ידי:

- הצטרפות לרמת המודעות הנוכחית של ההורה והבעת הבנה ואמפטיה לרגשות וצרכים הוריים (לא להתנהגויות) וכבוד או הבנה לאמונות ודרכי חשיבה שלו.
- הגדלת המורכבות החשיבתית על ידי דיאלוגים רפלקטיביים באמצעות הארת אינפורמציה חדשה וטיעונים נוספים מאותה רמת מודעות או הצבת פיגומים (Scaffolding)(ויגוצקי) לקראת הרמה הבאה מבחינה התפתחותית**.

שלבים ברמות מודעות הורית

רמה אגוצנטרית- ההורה מבין את הילד כהשלכה של הניסיון האישי שלו, והתפקיד ההורי מאורגן סביב צרכיו ורצונותיו של ההורה בלבד.

"...אין לי סבלנות וכח לשבת איתו. אני עובדת מספיק קשה בבית והוא עושה לי דווקא ולא יושב לבד. בעיה שלו אם לא ילמד.."

"היא חייבת להתאמן – אין מצב – אני לא אתן לה לעשות לי את זה, לזרוק את המתנה היקרה ביותר בעולם שאדם יכול לקבל, לזרוק את החיים כמו שאני עשיתי"

סיכון- כשהילד מתסכל צרכים אישיים חזקים של ההורה או כשההורה נזקק ביותר וחסר הפנמות נורמטיביות ביחס ל"שימוש" בילד או ל"טיפול" בו, כשצרכי הילד או דרישות המצב נחווים כתובעניים מדי עבור ההורה

רמה נורמטיבית- ההורה מבין את הילד על פי הגדרות והסברים של נורמות או מקור חיצוני (מסורת, תרבות, סמכות). תפקיד ההורה מאורגן סביב תפיסות מוגדרות-חברתית של חובות והתנהגויות נכונות.

"בימינו – בלי השכלה אתה כלום. אני לא מצפה ממנו להיות מצטיין, אבל הוא חייב לעשות מה שצריך ולהיות בסדר בלימודים. תפקידי להקפיד "חוסך שבטו שונא בנו"

"המורה אמרה שהשעורים צריכים להיות אחריות של הילד- אז אני לא מתערב"

סיכון- כשלילד אפיונים יוצאי דופן או כשהנורמות של המשפחה או תת-התרבות שאליה משתייך ההורה חריגים.

המשך- רמות מודעות הורית

- **רמה ממוקדת בילד-** ההורה רואה את הילד כפרט ייחודי המובן באמצעות יחסי ההורה-ילד. התפקיד ההורי מאורגן סביב זיהוי וסיפוק הצרכים של הילד יותר מאשר חובות תפקיד מוגדרות מראש ומקובלות.

"...הבן הגדול תמיד עשה שיעורים מיזמתו בזריזות ולא הייתי מעורבת. אבל עם שלומי אני רואה שקשה לו מאד להתחיל וקשה לו להתנתק מן הטלויזיה והמחשב. מצד שני הוא נכנס למתח נורא כשהשעורים שלו לא עשויים. אז אני עוזרת לו בהתארגנות לקראת: בודקים, רושמים משימות לאותו יום ויש צ'ופרים בסיום כל משימה. אני צריכה להיות בסביבה, ברוגע, כדי לעודד ולחזק. ירדתי לחצי משרה לפני שנה, למרות שזה קשה לנו כלכלית, אבל הבנתי שזה חשוב לשקט הנפשי שלו. אני מקדישה כל יום את אחר הצהריים לעניין השעורים שלו."

סיכון – הגנת-יתר ואינפנטיליזציה של הילד, שחיקה של ההורה ומחירים למערכת המשפחתית.

- **רמה הממוקדת ביחסים-** ההורה מבין את הילד כמערכת-עצמי פסיכולוגית מורכבת ומשתנה. ההורה מודע לכך שגם הוא מתפתח ומשתנה בתפקיד ושהתפקיד כולל מציאת דרכים לאזן את סיפוק צרכי הילד, וצרכים אישיים ומערכתיים אחרים. פרספקטיבה זו כוללת מימד של זמן ושל איזונים בין צרכי הפרטים במערכת המשפחתית.

סיכון – מורכבות וקושי לשמר לאורך זמן

מדריך תמציתי להתערבות על בסיס הערכת רמת המודעות ההורית:

רמה אגוצנטרית:

- קבל ותקף צרכים הוריים
- סמן קונבנציות הכרחיות (באמצעות ידע נורמטיבי תרבותי והתפתחותי, או דרישות החוק)
- ספק ידע חסר הקשור להגשמת הצרכים ההוריים וחפש דרכים שונות לספק צרכים אלה (פחות קונפליקטואליים ויותר מקובלים חברתית)
- העלאת מודעת לגבי חשיבותם עבור ילדיהם
- למד הרגעה עצמית וטפול-עצמי, עודד מציאת מקורות של הנאה ויחסים משמעותיים עם אחרים,
- סייע בבניית נרטיב קוהרנטי ומאוזן הקשור לצרכים ורגישויות מיוחדים

רמה נורמטיבית:

- קבל וכבד אמונות והצהרות הוריות
- הרחב והגמש תפיסות אלה על ידי אינפורמציה חדשה, השוואות או פרושים חדשים, מתוך עולם התרבות של ההורה, או מתוך עולם התרבות הדומיננטי
- חדד התבוננות השוואתית בלתי שיפוטית בין פרטים
- פתח דרכי היכרות ותקשורת סמלית עם הילד
- הגדל יעילות הורית על פי נתוני הילד המיוחדים

המשך- מדריך להתערבות

רמה ממוקדת בילד:

- הצטרף לדאגה ההורית והערך את ההשקעה וההתמסרות ההורית
- הרחב התפיסות של הילד וצרכיו כדי שתכלולנה פרספקטיבה התפתחותית מתאימה והסתכלות עתידית ובינאישית
- הרחב תפיסת ההורה לגבי תרומת יחסיו עם הילד כמעבדה ודגם ליחסים
- הגדל היכרות עם הכוחות והחוסן של הילד.

רמה הממוקדת ביחסים:

- הערך את מורכבות התפיסות
- עזור לארגן את התמונה המורכבת
- סייע בהצבת עדיפויות
- סייע בהעצמה תוך שימוש במשאבי עבר והווה ובניית אופטימיות לגבי העתיד

תהליך השינוי

- **המשגה טובה של הבעיה, תוך reframing (מסגור מחדש) התייחסותי מוצלח**
- **תהליך של הצטרפות ואיתגור-תוך התחשבות בconfirmation bias -** מבחינה מוחית-רגשית (פעילות האמיגדלה) אנחנו נותנים עדיפות לאינפורמציה שמאשרת את האמונות והידע הקודם שלנו מאשר מערערת אותם. לכן כדי לאפשר הפנמה של רעיון או ידע חדש יש למצוא את הדרך שתתקל בהכי פחות הגנתיות ובכל זאת תחדש ותאתגר.
- **רמת מודעות הורית (Cohen, 2004, 2006)-**מושג המתייחס למורכבות המערכת של שיקולי הדעת שמפעיל ההורה, כאשר הוא מנסה להבין את ילדו ולהחליט החלטות הוריות. ההנחה היא כי רמת מודעות מורכבת יותר, מאפשרת גמישות רבה יותר בהבנה של בעיית הילד ובמציאת פתרונות יצירתיים ומגוונים יותר. הכלל - עדיף להצטרף להורה ברמה שהוא נמצא בה כעת, ולהתקדם לקראת רמה אחת שמעליה. התקדמות זאת נעשית באמצעות דיאלוג רפלקטיבי-אפקטיבי ומכבד, ותוך הצבת פיגומים (ויגוצקי)

שליטה בהתנהגות תוקפנית של הילד

- ניתן לעשות "החזקה" של הילד בבית או בשעת טיפול לצורך הכלה ובטיחות כשהילד יוצא משליטה ואיננו ניתן לויסות בדרכים אחרות, ורק למשך הזמן שזקוק לו כדי להגיע לרמה סבירה של ויסות. מטרת ההורה (המטפל) לדאוג שהילד בטוח ומרגיש בטוח. המטרה איננה למשמע או לבטא תגובה רגשית שלילית כלפיו, אלא לעזור לו להרגיש בטוח ולווסת מצוקה באמצע הסגנון המקבל והבטוח של הוריו.
- התנהגויותיו השליליות של הילד מוכלות תוך אמפטיה וקבלה שהן קשורות בהיסטוריה שלו וברגשות (בדרך כלל בושה, חרדה, אשם) הקשורים אליה. חשוב שהילד יהיה מודע ויעשה עיבוד של אירועים אלה כדי שיבין כיצד משפיעים עליו עתה. ההבנות אינן "תירוצים" להתנהגות הלא-רצויה, אלא מציאות שיש להבין.
- ההורה מתחיל להבין שהתנהגויות ההימנעות או התוקפנות של הילד הם עבורו "מנגנוני הישרדות" שנלמדו במסגרת חוויות טראומטיות. התנהגויות אלה יפחתו ככל שהילד ירגיש בטוח יותר. ההתערבות סביבן לא נעשית כאקט של זעם או ביוש או מניעת אהבה ודחייה. הדגש הוא על עידוד והנאה מכל צעד קטן של התנהגות רצויה.

היכולת הורים להשתמש במשמעת מבלי לפגוע בהתקשרות.

1. מטרת משמעת היא ללמד, לא להעניש, לעזור לילד ללמוד ולא לבייש. אם מישהו במשפחה פגע באחר, המטרה היא שיחוש אשם ביחס להתנהגותו (לא בושה) ויפעל כדי לתקן את הקשר.
2. כאשר הורה ממשמע את ילדו הוא יהיה יעיל יותר אם יביע אמפטיה על הכשל ההתנהגותי או הבחירה הלא-מוצלחת של הילד, במקום כעס. כך הדגש הוא על ההתנהגות, בעוד שכעס ממקד את הדברים סביב הקשר במקום על ההתנהגות הלא-רצויה.
3. ההורה יכול להביע כעס כשמרגיש אותו חזק, אך צריך להביעו בצורה עניינית וממוקדת, ולא לסחוב אותו זמן רב, אלא לחזור לקשר מתוקן, לאחר שהילד נשא בתוצאות או נערך תיקון.

והחמלה -
הנשימה החמימה הנושבת ביקום
מרככת את בשרנו הבהול תמיד קדימה
ומעלה את הבכי הכמוס, הפנימי
כשמשהו מחרך הראייה שכבר נפער בנו
משהו משם תמיד
רואה
רחום על היותנו אנשים,
חנון על השכמות שכה מתגעגעות למעוף

אגי משעול